

Contexto Formativo

Gestión de recursos laborales, formativos y

análisis de puestos de trabajo para la

inserción sociolaboral de personas con discapacidad

**GUÍA PROFESIONAL PARA DOCENTES, ORIENTADORES LABORALES Y
TÉCNICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL**

INTRODUCCIÓN: MARCOS CONCEPTUALES Y PRINCIPIOS DE ACCIÓN

La discapacidad no es un atributo de la persona.

Esta afirmación, que puede parecer contraintuitiva cuando llevamos décadas escuchando lo contrario, constituye el punto de partida de cualquier práctica profesional coherente con lo que sabemos hoy sobre cómo las personas con discapacidad viven, aprenden y participan en la sociedad.

El modelo médico o rehabilitador, que dominó gran parte del siglo XX, situaba el problema dentro del individuo. La persona con una lesión medular tenía un déficit que había que compensar, rehabilitar o, en su defecto, gestionar. El objetivo era acercarla lo máximo posible a la norma funcional establecida por la mayoría. Este enfoque no era malicioso. Respondía a una lógica científica de su época. Pero tenía un efecto silencioso y devastador: convertía a la persona en objeto de intervención y a los profesionales en árbitros de lo que esa persona podía o no podía hacer.

El modelo social, desarrollado con fuerza desde los años setenta y ochenta por el propio colectivo de personas con discapacidad, invirtió esta lógica. El problema no está en la persona. Está en cómo están diseñados los entornos, las instituciones, los sistemas educativos y los mercados laborales. Una persona que utiliza silla de ruedas no tiene un problema de movilidad en un edificio sin escaleras. El problema surge cuando hay escaleras y no hay rampa. La discapacidad, desde este modelo, es el resultado de la interacción entre una condición de salud y los obstáculos que el entorno impone.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), aprobada por la OMS en 2001, recogió esta visión integradora. El funcionamiento de una persona depende de su condición de salud, pero también de los factores contextuales: el entorno físico, social y actitudinal, y los factores personales como la edad, el sexo, la experiencia o la motivación. Dos personas con exactamente el mismo diagnóstico pueden tener niveles de participación radicalmente diferentes en función del entorno en que viven.

Definiciones

Conviene aclarar cuatro términos que en la práctica profesional se utilizan con frecuencia de forma intercambiable, pero que describen realidades distintas.

DEFICIENCIA
Pérdida o anomalía en una estructura o función corporal, ya sea anatómica, fisiológica o psicológica.
Es un hecho clínico observable o medible.
Ejemplos: deficiencia visual, auditiva o cognitiva.
La deficiencia describe la condición. No determina por sí sola la participación de la persona.

DISCAPACIDAD

Restricción en la capacidad de realizar actividades en la forma o dentro del margen que se considera habitual.

Emerge de la interacción entre la deficiencia y el entorno. Es relacional, no es una propiedad fija.

La misma deficiencia puede generar discapacidad o no, dependiendo del entorno.

El entorno accesible reduce o elimina la discapacidad. El entorno inaccesible la genera o la amplifica.

DIVERSIDAD FUNCIONAL

Término promovido desde el movimiento de personas con discapacidad para sustituir denominaciones que implican carencia o déficit.

Pone el énfasis en que las personas funcionan de maneras distintas, no de maneras incorrectas.

Tiene una carga política y de reivindicación de derechos.

Su uso creciente refleja el cambio de paradigma hacia la autonomía y la autodeterminación.

DEPENDENCIA

Situación en la que una persona necesita apoyo de otra para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria.

La dependencia NO es sinónimo de discapacidad.

Hay personas con discapacidad totalmente autónomas.

Hay personas sin discapacidad que generan situaciones de dependencia por edad avanzada u otras causas.

Se regula en España mediante la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal.

La diferencia entre integración e inclusión

La integración parte de la idea de que la persona con discapacidad debe adaptarse al entorno normalizado. El aula estándar existe y la persona entra en ella. Si puede seguir el ritmo, bien. Si no puede, se le dan apoyos para que se acerque lo máximo posible al estándar.

La inclusión parte del principio contrario: es el entorno el que debe adaptarse para que la participación de todas las personas sea posible desde el principio. El aula inclusiva no es aquella en la que hay un alumno con discapacidad más una adaptación añadida. Es aquella que está diseñada desde el inicio para que cualquier persona, con o sin discapacidad, pueda aprender en ella.

Los principios que articulan la inclusión son: universalidad en el acceso, participación plena, ausencia de discriminación, ajustes razonables, y respeto a la autonomía y a la toma de decisiones de cada persona.

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

El DUA no es una metodología para alumnos con discapacidad. Es un marco de diseño curricular que parte de la evidencia neurocientífica sobre cómo aprenden los seres humanos y que busca crear entornos de aprendizaje que funcionen para la mayor diversidad posible de personas desde el principio, sin necesidad de adaptaciones posteriores.

El DUA se articula en tres principios fundamentales, derivados de la investigación sobre redes neuronales implicadas en el aprendizaje:

Principio DUA	Qué implica	Ejemplo en el aula
Múltiples formas de representación	La información se presenta de maneras diversas para que distintas personas puedan acceder a ella	Combinar explicación oral, texto escrito, esquemas visuales y ejemplos concretos en cada tema
Múltiples formas de acción y expresión	Las personas demuestran lo que saben de maneras distintas	Ofrecer como alternativas: exposición oral, informe escrito, demostración práctica o portfolio
Múltiples formas de implicación	Las personas se motivan de formas distintas y mantienen la atención de maneras distintas	Dar opciones de elección en actividades, conectar contenidos con intereses del alumnado, permitir la autorregulación del ritmo de aprendizaje

Accesibilidad universal

La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, productos, servicios y sistemas de comunicación para que todas las personas puedan utilizarlos en condiciones de igualdad. No es una adaptación especial. Es una condición de diseño.

En el contexto formativo, la accesibilidad implica al menos cuatro dimensiones: física (espacios transitables sin barreras arquitectónicas), comunicativa (información disponible en formatos accesibles para personas con distintas capacidades sensoriales o cognitivas), actitudinal (ausencia de prejuicios y estereotipos que dificulten la participación) y tecnológica (herramientas digitales compatibles con tecnologías de apoyo como lectores de pantalla o amplificadores de imagen).

Un aula accesible no es aquella en la que hay una rampa. Es aquella en la que nadie necesita pedir permiso para participar.

CAPÍTULO 1: LA EXPERIENCIA HUMANA DE LA DISCAPACIDAD

Antes de cualquier protocolo de intervención, antes de cualquier adaptación metodológica y antes de cualquier lista de cotejo de aula accesible, hay una pregunta que todo docente o técnico que trabaje con personas con discapacidad debería ser capaz de responder con honestidad: ¿qué se siente cuando el entorno que se supone que debe enseñarte o ayudarte está diseñado sin tener en cuenta tu forma de estar en el mundo?

La respuesta no tiene nada que ver con el diagnóstico. Tiene que ver con la experiencia acumulada de encontrar obstáculos donde otros no los ven, de tener que explicar constantemente lo que necesitas, de ser evaluado según parámetros que no contemplan tu manera de funcionar, y de percibir en los ojos de quienes te rodean una mezcla de lástima, incomodidad y buena voluntad que, paradójicamente, puede ser más paralizante que la propia barrera física.

1.1 Qué ocurre cuando se encuentran barreras

Una barrera no es solo un escalón. Es cualquier elemento del entorno que impide o dificulta la participación de una persona. Puede ser arquitectónica, pero también puede ser comunicativa, actitudinal, organizativa o tecnológica.

Cuando una persona con discapacidad se encuentra una barrera, lo que experimenta no es simplemente inconveniencia. Lo que experimenta es exclusión. Y la exclusión repetida tiene un impacto psicológico documentado que va mucho más allá del episodio concreto.

En el ámbito educativo y formativo, las barreras más frecuentes son a menudo invisibles para el docente. Un material proyectado sin suficiente contraste no es problema para el 80% del aula. Para el alumno con baja visión, es una sesión completa de información perdida. Una instrucción compleja dada verbalmente a ritmo normal no supone ningún esfuerzo para la mayoría. Para la persona con discapacidad intelectual o con procesamiento auditivo alterado, puede ser una fuente de ansiedad intensa que, si se repite sistemáticamente, lleva al abandono.

El problema no está en la instrucción compleja. Está en que se haya dado por sentado que todos la procesarán igual.

1.2 El impacto psicológico de la sobreprotección

Hay una forma de barrera que los profesionales rara vez reconocen como tal porque surge de la mejor de las intenciones: la sobreprotección.

Sobreproteger a una persona con discapacidad significa asumir, antes de preguntar, qué puede y qué no puede hacer. Significa anticiparse a sus necesidades sin consultarle. Significa tomar decisiones en su nombre. Significa reducir las expectativas de rendimiento hasta un punto en

que la persona deja de tener que esforzarse. Y significa transmitirle el mensaje de que no se confía en su capacidad.

Las consecuencias de la sobreprotección sostenida son graves y están bien documentadas en la literatura sobre psicología de la discapacidad. La persona aprende que no tiene control sobre su entorno y que sus decisiones no importan, lo que lleva a lo que la investigación denomina indefensión aprendida: un estado en el que la persona deja de intentarlo porque ha aprendido que sus intentos no producen resultados. Se reduce la motivación intrínseca. Disminuye la autoestima. Se deteriora la capacidad de autodeterminación.

Un docente sobreprotector que simplifica los contenidos sin consensuarlo con el alumno, que resuelve los problemas antes de que el alumno los intente, o que exime de responsabilidades «para no sobrecargar», está causando un daño real aunque su intención sea proteger.

"El peor momento de mis años de formación no fue cuando no podía llegar a algún sitio por las escaleras. El peor momento fue cuando la profesora me dijo que no me preocupara por la parte de presentación oral, que con el trabajo escrito era suficiente. No me lo preguntó. Lo decidió. Y yo me quedé sin poder demostrar que podía hacerlo. Eso duele más que cualquier escalón."

— Ana, 34 años, discapacidad física por lesión medular

1.3 Fatiga social y carga cognitiva invisible

Las personas con discapacidad, especialmente aquellas con condiciones que no son visibles a simple vista, experimentan con frecuencia lo que se denomina fatiga social: un agotamiento específico que resulta no de la actividad en sí misma sino del esfuerzo continuo de adaptarse a un entorno que no está pensado para ellas.

Una persona con discapacidad auditiva que lleva toda la sesión leyendo los labios del docente, intentando seguir las intervenciones de diferentes compañeros, procesando la información escrita simultáneamente y gestionando la ansiedad de haberse perdido fragmentos de información no está descansando cuando termina la clase. Está agotada de una manera que sus compañeros no comprenden porque exteriormente ha estado sentada exactamente igual que ellos.

Una persona con TEA que ha pasado tres horas gestionando la imprevisibilidad de la dinámica de grupo, filtrando el ruido ambiental, procesando las señales sociales del entorno y manteniendo la conducta socialmente esperada ha realizado un esfuerzo cognitivo y emocional que no tiene parangón con lo que han experimentado sus compañeros neurotípicos.

Esta fatiga es real, tiene base neurobiológica y tiene consecuencias directas sobre la capacidad de aprendizaje, la concentración y la regulación emocional. Ignorarla lleva a interpretar como falta de interés, mal comportamiento o bajo rendimiento lo que en realidad es el resultado de haber llegado al límite de los recursos disponibles.

1.4 El estigma y sus efectos

El estigma asociado a la discapacidad no ha desaparecido. Ha cambiado de forma. Ya no se expresa abiertamente en la mayoría de los contextos educativos o laborales, pero persiste en formas más sutiles: la mirada que se dirige a la silla de ruedas antes que al rostro de la persona; el tono de voz que se eleva automáticamente cuando se habla con alguien con discapacidad visual, como si ver mal implicara también oír mal; la pregunta «¿pero puede trabajar en serio?» cuando se plantea la inserción laboral de una persona con discapacidad intelectual.

El estigma tiene un efecto específicamente documentado sobre el rendimiento académico: el efecto amenaza del estereotipo, descrito por Claude Steele en los años noventa, muestra que las personas pertenecientes a grupos estigmatizados pueden ver su rendimiento reducido en situaciones en las que el estereotipo negativo es saliente. Simplemente el hecho de que se sepa que pertenecen a un grupo al que se atribuyen menos capacidades puede interferir con el rendimiento.

Para un docente, esto significa que el modo en que se introduce o gestiona la cuestión de la discapacidad en el aula tiene consecuencias directas sobre el rendimiento de los alumnos afectados.

1.5 Autoestima, identidad y autodeterminación

La identidad de una persona no se reduce a su diagnóstico. Este principio, que parece obvio cuando se enuncia, es sistemáticamente violado en la práctica cuando se habla de «el discapacitado» en lugar de «la persona», cuando se describe a alguien por su condición antes que por sus características como persona, o cuando se diseña un itinerario formativo o laboral basado exclusivamente en las limitaciones en lugar de en las capacidades.

La autodeterminación es la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida, de establecer metas, de iniciar acciones para alcanzarlas y de evaluar los resultados. Es un componente fundamental del bienestar y de la calidad de vida. La investigación sobre discapacidad y calidad de vida muestra de forma consistente que las personas con mayor nivel de autodeterminación tienen mejor bienestar subjetivo, mayor participación social y mejor inserción laboral, independientemente de la naturaleza o severidad de su discapacidad.

Un sistema formativo o de orientación laboral que no tiene como objetivo central el desarrollo de la autodeterminación de la persona no está haciendo bien su trabajo.

"Todo el mundo me decía lo que podía y no podía hacer. En el centro de día me enseñaron a doblar ropa. En el CEE hacía cajas. Nadie me preguntó nunca si eso era lo que yo quería hacer. Un día llegó una orientadora nueva y me preguntó qué me gustaba. Le dije que los coches. Que me pasaba horas en YouTube viendo vídeos de mecánica. Me miró sorprendida, como si eso fuera inesperado. Para mí no lo era. Era mi vida."

— Carlos, 28 años, discapacidad intelectual leve

1.6 El derecho a la presencia y a la participación

Hay una diferencia entre estar físicamente presente en un aula y participar de forma activa y significativa en lo que ocurre en ella. Durante décadas, la integración física se confundió con la inclusión. Se interpretó que el hecho de que una persona con discapacidad estuviera en el

mismo espacio que sus iguales era en sí mismo un logro. No se cuestionaba si esa persona estaba aprendiendo, relacionándose o creciendo en ese espacio al mismo nivel que los demás.

La participación plena exige que el entorno esté diseñado de forma que la persona no tenga que hacer un esfuerzo adicional simplemente para acceder a lo que el resto tiene de forma automática. No es un privilegio. Es un derecho.

Tabla 1.1 — Experiencia vivida de la discapacidad en contextos formativos

Dimensión	Experiencia frecuente	Impacto observable
Barreras físicas	Espacios no accesibles, materiales no adaptados	Exclusión de actividades, dependencia de terceros
Barreras comunicativas	Información en un único formato, ritmo inadecuado	Pérdida de contenido, fatiga, ansiedad sostenida
Estigma	Expectativas reducidas, trato diferenciado sin causa	Reducción del rendimiento, baja autoestima
Sobreprotección	Toma de decisiones sin consulta a la persona	Indefensión aprendida, pérdida de autonomía
Fatiga invisible	Sobreesfuerzo de adaptación continuo al entorno	Agotamiento, reducción de la concentración
Participación limitada	Presencia física sin voz ni protagonismo real	Desconexión progresiva, abandono del proceso

1.7 Errores frecuentes en este ámbito

Identificar los errores más habituales no tiene como objetivo señalar a los profesionales sino ofrecer un punto de partida para la reflexión. Todos estos errores tienen alternativas concretas.

Error frecuente	Alternativa recomendada
Hablar sobre la persona en su presencia como si no estuviera	Dirigirse siempre directamente a la persona, en primer lugar
Asumir las limitaciones antes de preguntar	Preguntar en privado qué necesita y qué prefiere
Reducir la exigencia sin consensuarlo	Consensuar los ajustes con la persona manteniendo expectativas altas
Identificar a la persona por su diagnóstico	Usar lenguaje centrado en la persona: 'persona con...' no 'el/la discapacitado/a'
Interpretar la fatiga como falta de interés	Incorporar descansos y preguntar cómo se encuentra la persona
Excluir de actividades 'para no sobrecargar'	Adaptar la actividad para que la participación sea posible

Recursos y normativa de referencia

- Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) — OMS, 2001
- Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad — 2006, ratificada por España en 2008
- Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (LGDPD)
- CAST — Center for Applied Special Technology: marco DUA (udlguidelines.cast.org)
- CERMI — Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (cermi.es)
- ONCE — Organización Nacional de Ciegos Españoles (once.es)

CAPÍTULO 2: DISCAPACIDAD FÍSICA

2.1 Cómo se experimenta una sesión formativa

La experiencia de una persona con discapacidad física en un contexto formativo depende de factores que los docentes suelen no considerar porque no forman parte de su experiencia cotidiana: la accesibilidad del espacio, la distribución del mobiliario, la duración de las sesiones sin posibilidad de cambiar de postura, la gestión del dolor o la fatiga, y la organización de las actividades prácticas.

Una persona que utiliza silla de ruedas no solo necesita que las puertas sean suficientemente anchas para entrar. Necesita que la mesa de trabajo esté a una altura adecuada. Necesita que los materiales no estén en estanterías inaccesibles. Necesita que el aula esté organizada de forma que pueda moverse sin depender de que otros aparten sillas. Necesita que los talleres o espacios de práctica tengan el mismo nivel de accesibilidad que las aulas teóricas, algo que con frecuencia no ocurre.

Una persona con parálisis cerebral que tiene control motor reducido en las manos puede necesitar más tiempo para escribir, software de escritura por voz, o formatos de evaluación que no requieran escritura manual. Ninguna de estas necesidades implica menor capacidad intelectual. Son adaptaciones del canal, no del contenido.

Una persona con esclerosis múltiple puede tener días en que funciona con muy poca limitación y días en que la fatiga o el dolor hacen que la participación normal sea imposible. Esta variabilidad no es falta de compromiso. Es la naturaleza de su condición, y exige del docente una flexibilidad que no es injusticia hacia el resto del grupo: es equidad.

2.2 Las dificultades invisibles

Hay un aspecto de la discapacidad física que los docentes frecuentemente ignoran porque no es visible: el dolor crónico y la fatiga.

Una persona con artritis reumatoide, con distrofia muscular o con lesiones traumáticas puede presentar un aspecto externo de relativa normalidad mientras gestiona de forma continua niveles de dolor que interferirían gravemente con la concentración de cualquier persona. El dolor crónico consume recursos cognitivos. Reduce la capacidad de atención sostenida. Deteriora la memoria de trabajo. Afecta al estado de ánimo de formas que pueden malinterpretarse como falta de interés o mal carácter.

La fatiga en enfermedades neuromusculares no es cansancio ordinario que se resuelve con descanso. Es una limitación fisiológica real que hace que la realización de ciertas tareas sea literalmente imposible pasado cierto punto, independientemente de la motivación o la voluntad de la persona.

" Testimonio simulado — Marta, 42 años, esclerosis múltiple remitente-recurrente:

"Hay días que llego al aula y desde fuera parezco perfectamente bien. Pero llevo dos horas calculando cuánta energía tengo, si podré aguantar toda la sesión sin que me falle la pierna derecha, si el nivel de espasticidad de hoy me permitirá escribir o si necesitaré grabar la clase. Mientras el docente explica, yo hago estos cálculos. Nadie lo sabe. Y si pido algo, la mirada es de sorpresa, como si mi aspecto exterior desacreditara mi necesidad."

2.3 Errores frecuentes del docente

Error 1 — Hablar sobre la persona a través de un acompañante. Dirigirse al asistente personal o al compañero que ayuda en lugar de hablar directamente con la persona. La persona con discapacidad física raramente tiene alterada la capacidad de comunicación.

Error 2 — Sobreestimar las limitaciones. Asumir que una persona en silla de ruedas no puede participar en dinámicas, salidas o prácticas sin haber evaluado primero qué adaptaciones permitirían su participación.

Error 3 — Tratar la accesibilidad como «problema del centro». El docente puede reorganizar el mobiliario, elegir el aula más accesible cuando hay opciones y comunicar proactivamente las necesidades a la institución. No hacerlo también es una decisión.

Error 4 — No preguntar. La forma más eficiente de saber qué adaptaciones necesita un alumno es preguntarle directamente, de forma privada, al inicio del proceso.

Error 5 — Infantilizar. Hablar en tono más lento o más simple del que se usa con el resto del grupo cuando no hay ningún motivo para ello.

2.4 Buenas prácticas

Antes de que empiece el curso: verificar personalmente la accesibilidad del espacio; identificar los momentos de la programación que pueden requerir adaptaciones (prácticas, salidas, evaluaciones); establecer una conversación privada con el alumno para conocer sus necesidades y preferencias.

Durante las sesiones: organizar el espacio para que el alumno tenga acceso al mismo nivel de participación que el resto; incorporar descansos regulares y hacer de ello una norma de aula para todos; ofrecer alternativas en actividades que requieren movilidad o destreza motora fina; asegurarse de que todos los materiales están en formatos accesibles.

En la evaluación: diseñar instrumentos que midan el conocimiento y las competencias, no la velocidad de escritura manual ni la capacidad de realizar tareas que dependen de habilidades motoras que no son el objeto de evaluación.

Tabla 2.1 — Discapacidad física en contextos formativos

Aspecto	Situación habitual	Estrategia recomendada
Acceso al espacio	Barreras arquitectónicas, mobiliario fijo	Verificación previa, reorganización del espacio
Fatiga y dolor	Invisible para el docente	Descansos regulares, flexibilidad horaria
Actividades prácticas	Diseñadas sin accesibilidad	Adaptación previa, alternativas equivalentes
Evaluación	Formatos que requieren habilidad motora	Instrumentos alternativos que midan el conocimiento
Comunicación	Dirigida a acompañantes	Comunicación directa con la persona siempre
Variabilidad sintomática	Interpretada como inconsistencia	Flexibilidad, plan de contingencia pactado

CAPÍTULO 3: DISCAPACIDAD VISUAL

3.1 Cómo perciben materiales, diapositivas y espacios

La discapacidad visual no es binaria. Entre la visión normal y la ceguera total existe un amplio espectro de condiciones que producen experiencias perceptivas muy diferentes entre sí. Una persona con miopía degenerativa avanzada puede tener una visión central muy limitada pero conservar algo de visión periférica. Una persona con glaucoma puede haber perdido gran parte del campo visual periférico pero mantener una agudeza central relativamente funcional. Una persona con albinismo puede tener fotofobia intensa que hace que los entornos muy iluminados resulten especialmente limitantes.

Esta variabilidad tiene una implicación práctica directa: no existe una solución única válida para todos los alumnos con discapacidad visual. Las adaptaciones deben partir del conocimiento de la situación específica de cada persona, nunca de una plantilla genérica.

Lo que sí comparten muchas personas con discapacidad visual en los entornos formativos es la experiencia de encontrar materiales diseñados exclusivamente para personas con visión normal. Diapositivas con texto pequeño sobre fondos de colores de contraste insuficiente, vídeos sin audiodescripción, documentos escaneados que un lector de pantalla no puede procesar, esquemas gráficos sin descripción textual, pizarras escritas con letra pequeña: todas estas son barreras habituales en cualquier aula, y casi ninguna requiere presupuesto adicional para resolverse, solo previsión.

3.2 Simulación: una sesión formativa desde la perspectiva de un alumno con baja visión

Son las nueve de la mañana. El aula huele a café. Me siento en la segunda fila porque desde el fondo no distingo nada de lo que se proyecta. El docente ha preparado unas diapositivas con fondo oscuro y texto en un tono ligeramente más claro. Puedo intuir que hay texto ahí pero no leerlo. Podría pedir que me las mande en formato digital después, pero ya le he pedido tres veces lo mismo este trimestre y noto que molesta.

El docente empieza a hablar señalando cosas en la pantalla. «Como veis aquí...», dice. No veo. Proceso la información solo a través del audio, intentando reconstruir mentalmente lo que está señalando. Cuando cambia de diapositiva lo noto por el cambio en el tono de su voz, no porque vea la pantalla.

A mi derecha, una compañera ha sacado el móvil para hacer fotos a las diapositivas. Yo también podría hacerlo, pero el tamaño del texto sigue siendo demasiado pequeño incluso en la foto ampliada. Llevo cuarenta minutos de sesión y no he podido acceder de forma autónoma a ninguno de los materiales visuales presentados.

No me he quejado. He aprendido que quejarse genera incomodidad, que la incomodidad genera distancia, y que la distancia en un proceso formativo perjudica más que la barrera original.

3.3 Tecnologías de apoyo

Las personas con discapacidad visual disponen de tecnologías que pueden facilitar significativamente su participación, siempre que el entorno esté preparado para que funcionen correctamente.

Los **lectores de pantalla** (JAWS, NVDA) permiten a las personas ciegas acceder a contenido digital mediante síntesis de voz. Para que funcionen, los documentos deben estar en formatos accesibles —Word o PDF etiquetado—, nunca como imágenes de texto. Un PDF escaneado sin etiquetado es completamente inaccesible para un lector de pantalla, por mucho que «se vea el texto».

Las **líneas braille refrescables** traducen el texto digital a braille táctil. Son especialmente útiles para contenidos técnicos o matemáticos donde la síntesis de voz puede resultar confusa o ambigua.

Los **amplificadores de pantalla** (ZoomText, o la amplificación nativa del sistema operativo) permiten a personas con baja visión acceder al contenido ampliado. Para que sean efectivos, los materiales deben mantener legibilidad al ampliarse, no degradarse en imágenes de baja resolución.

La **audiodescripción** en vídeos permite acceder al contenido visual que se transmite en materiales audiovisuales. Es una adaptación que el docente puede solicitar al seleccionar materiales, o proporcionar de forma verbal durante la proyección si no existe versión oficial.

3.4 Adaptaciones metodológicas

Primer principio: anticipación. Proporcionar los materiales con tiempo suficiente para que la persona pueda prepararlos. Un documento enviado la noche anterior no basta para quien necesita convertirlo a un formato accesible y procesarlo con un lector de pantalla.

Segundo principio: descripción verbal sistemática. Cuando se presenta un gráfico, diagrama o imagen, el docente debe describirlo con suficiente detalle para que alguien que no puede verlo obtenga la misma información que el resto del grupo.

Tercer principio: legibilidad de todos los materiales escritos. Fuente mínima de 14 puntos en documentos impresos, contraste suficiente entre texto y fondo, evitar fondos con texturas o imágenes que interfieran con la lectura.

Cuarto principio: accesibilidad digital real. Todos los documentos en formatos que permitan la lectura por lectores de pantalla. Un PDF debe ser un PDF accesible, no una fotografía del texto convertida a PDF.

Tabla 3.1 — Discapacidad visual en contextos formativos

Tipo	Experiencia en el aula	Tecnologías de apoyo	Adaptaciones clave
Baja visión	Dificultad con materiales de contraste bajo o texto pequeño	Amplificadores de pantalla, lupas	Documentos en letra grande, alto contraste
Ceguera	Sin acceso a contenido visual no descrito	Lectores de pantalla, línea braille	Documentos accesibles, descripción verbal de visuales
Fotofobia	Dificultad en espacios muy iluminados	Filtros de pantalla, gafas especiales	Control de iluminación, pantallas sin reflejo
Visión tubular (glaucoma avanzado)	Dificultad para localizar elementos fuera del centro visual	Reorganización de pantalla, navegación guiada	Disposición simple y predecible de materiales

CAPÍTULO 4: DISCAPACIDAD AUDITIVA

4.1 Las barreras de comunicación en entornos formativos

La discapacidad auditiva engloba un espectro que va desde la hipoacusia leve, corregible parcialmente con audífonos, hasta la sordera profunda bilateral, en la que no existe percepción auditiva funcional incluso con amplificación.

La barrera fundamental que encuentran las personas con discapacidad auditiva en los entornos formativos no es la incapacidad de oír sonidos. Es la incapacidad de acceder a la comunicación que ocurre en esos entornos cuando esta se produce exclusivamente por vía oral y sin adaptación.

Un docente que explica de espaldas a la pizarra mientras escribe es inaccesible para alguien que lee los labios. Un debate en el que varias personas hablan simultáneamente o se interrumpen entre sí es inaccesible para quien necesita concentrarse en un único interlocutor. Un vídeo sin subtítulos es completamente inaccesible. Una alarma solo sonora es inaccesible.

La lengua de signos no es una versión simplificada del castellano oral. Es una lengua completa con gramática, sintaxis y morfología propias. La Lengua de Signos Española (LSE) tiene estructuras gramaticales que difieren significativamente del español oral. Para muchas personas sordas, especialmente quienes perdieron la audición antes de adquirir el lenguaje oral, la LSE es su primera lengua. El castellano escrito puede ser su segunda lengua, con las implicaciones que eso tiene para la comprensión de textos y la producción escrita.

4.2 Lengua de signos y lectura labial: realidades que el docente debe conocer

Existe un mito extendido que merece abordarse directamente: la creencia de que las personas con discapacidad auditiva que usan audífonos o implante coclear pueden seguir la comunicación oral sin problemas. No es así en la mayoría de los casos.

Los audífonos amplifican el sonido, pero no restauran la audición normal. En entornos con ruido de fondo, con múltiples fuentes de sonido o con acústica deficiente, la comprensión puede ser muy limitada incluso con amplificación. Los implantes cocleares ofrecen mayor funcionalidad, pero también tienen limitaciones importantes en contextos ruidosos o con varios interlocutores simultáneos.

La lectura labial es una estrategia que muchas personas desarrollan como complemento, pero tiene límites que los docentes desconocen con frecuencia. Solo entre un 30 y un 40% de los sonidos del español son visibles en los labios con claridad; el resto se deduce por contexto. Esto significa que la lectura labial es siempre una interpretación parcial, no una decodificación completa. El cansancio aumenta de forma significativa tras períodos

prolongados de lectura labial, y requiere ver el rostro del interlocutor a una distancia máxima de unos dos metros, con buena iluminación facial.

Un docente que da clase de espaldas o de perfil, que habla mientras borra la pizarra, que se cubre la boca con la mano o que proyecta con la luz del proyector de frente —quedando él mismo en sombra— hace la lectura labial imposible.

4.3 Subtitulación y apoyos tecnológicos

La **subtitulación en tiempo real** (CART, Communication Access Realtime Translation) permite que lo que se dice en el aula aparezca como texto en pantalla o en el dispositivo del alumno. Es la adaptación más efectiva en contextos formativos, y su disponibilidad mejora gracias a herramientas de transcripción automática como Google Live Transcribe o Microsoft Azure Speech Service.

Los **sistemas de bucle magnético o FM** reducen el ruido de fondo y transmiten directamente la voz del docente al audífono o implante. Su disponibilidad en los centros es variable, pero debería considerarse en los planes de accesibilidad.

Los **intérpretes de lengua de signos** son necesarios cuando el alumno usa LSE como lengua principal. Su presencia requiere planificación específica: el intérprete necesita material previo, el alumno necesita ver simultáneamente al intérprete, al docente y los materiales visuales, y el ritmo del aula debe adaptarse a los tiempos de interpretación.

4.4 Cómo adaptar dinámicas grupales

Las dinámicas grupales son especialmente difíciles porque en ellas se producen conversaciones simultáneas, interrupciones y solapamientos que hacen imposible seguir el hilo sin apoyos específicos.

Estrategias eficaces: establecer un turno de palabra claro y respetado por todos; asegurarse de que quien habla es siempre visible para el alumno con discapacidad auditiva; resumir verbalmente y por escrito los puntos principales a intervalos regulares; usar herramientas de comunicación escrita complementarias, como pizarras digitales compartidas o documentos colaborativos; y posicionar al alumno de forma que tenga visibilidad de todos los participantes, nunca de espaldas a nadie.

" Testimonio simulado — Javier, 26 años, sordo profundo bilateral usuario de LSE:

"El docente empezaba la clase y yo miraba al intérprete. El intérprete llegaba tarde dos de cada cinco días. Esos días me sentaba y copiaba lo que veía en la pizarra sin entender el contexto. En los debates grupales todo pasaba demasiado rápido. Para cuando el intérprete me transmitía lo que había dicho alguien y yo respondía en signo y el intérprete lo verbalizaba, el grupo ya estaba en otro punto. Aprendí a no intervenir. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque el ritmo de acceso no era el mismo."

4.5 El impacto de la identidad Sorda

Existe una distinción relevante que todo profesional debería conocer: la diferencia entre «sordo» con minúscula, que describe una condición audiológica, y «Sordo» con mayúscula, que describe una identidad cultural y lingüística.

Las personas Sordas que se identifican culturalmente con la comunidad Sorda no necesariamente consideran su sordera una discapacidad que deba ser compensada o curada. Tienen una lengua propia, una cultura propia, una historia propia y una comunidad. Abordar la sordera exclusivamente desde el modelo médico con estas personas puede resultar ofensivo y generar desconfianza.

Implicaciones prácticas en el aula: no asumir que el objetivo de todo alumno con sordera es maximizar el uso del castellano oral; respetar la preferencia lingüística de cada persona; no tratar la LSE como una solución de recurso, sino como una lengua completa y legítima.

Tabla 4.1 — Discapacidad auditiva en contextos formativos

Situación	Barrera	Adaptación
Explicación oral	Sin acceso si no hay visión del docente	Asegurar visibilidad del rostro, subtitulación
Vídeos	Sin subtítulos = inaccesible	Subtítulos en todos los materiales audiovisuales
Debate grupal	Múltiples voces simultáneas	Turno de palabra, resúmenes escritos
Instrucciones complejas	Solo canal oral	Instrucciones también por escrito
Evaluación oral	Dificultad en canal oral en tiempo real	Alternativas escritas o con intérprete
Identidad lingüística	Asunción de preferencia por el oralismo	Preguntar y respetar la lengua preferida de cada persona

CAPÍTULO 5: DISCAPACIDAD INTELECTUAL

5.1 Procesamiento cognitivo: qué significa realmente

La discapacidad intelectual se define por la coexistencia de tres criterios: un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media (por debajo de un CI de 70), dificultades relevantes en dos o más habilidades adaptativas, y una manifestación anterior a los 18 años. Pero esta definición clínica dice muy poco sobre lo que ocurre realmente en un aula.

El procesamiento cognitivo de una persona con discapacidad intelectual no es «más lento» de forma uniforme. Es distinto en su organización. Suele costar más procesar información abstracta o simbólica que información concreta y vinculada a la experiencia directa. Suele costar más mantener varios pasos en la memoria de trabajo simultáneamente. Suele costar más generalizar un aprendizaje de un contexto a otro: una persona puede aprender perfectamente a usar una herramienta en el taller del centro formativo y no transferir espontáneamente esa habilidad a un taller distinto si nadie le ha enseñado explícitamente a hacer esa generalización.

Esto no significa incapacidad de aprender. Significa que el aprendizaje requiere una secuenciación más explícita, más práctica distribuida en el tiempo, y más oportunidades de aplicar lo aprendido en contextos variados antes de darlo por consolidado.

5.2 Comprensión de instrucciones

Una instrucción como «preparad el material para la próxima sesión, revisad el capítulo tres y traed alguna duda» contiene, en realidad, tres instrucciones encadenadas, dos conceptos abstractos («revisar», «alguna duda») y una proyección temporal a un momento futuro. Para muchas personas con discapacidad intelectual, esa frase no se procesa como una secuencia clara de pasos, sino como un bloque de información del que solo se retiene un fragmento, habitualmente el primero o el último.

Esto no es un problema de atención ni de actitud. Es la forma en que se organiza el procesamiento del lenguaje complejo. La solución no consiste en repetir la misma frase más alto o más despacio, sino en descomponerla.

Instrucción reformulada: «Primero, abrid el libro por la página cuarenta. Segundo, leed hasta el final de la página. Tercero, escribid una pregunta sobre lo que no hayáis entendido». Tres pasos, secuenciados, con verbos de acción concretos y sin proyección temporal ambigua.

5.3 Ritmo de aprendizaje y necesidad de apoyos

El ritmo de aprendizaje variable no implica un techo de aprendizaje bajo. Implica que la curva de adquisición es distinta: a menudo se necesita más repetición espaciada para consolidar un

contenido, pero una vez consolidado, se retiene con la misma estabilidad que en cualquier otra persona.

Los apoyos no son un favor ni una rebaja del nivel exigido. Son el equivalente funcional de unas gafas para alguien con miopía: no cambian lo que la persona es capaz de comprender, cambian el canal por el que accede a esa comprensión. Los apoyos más eficaces en contextos formativos incluyen: el uso sistemático de pictogramas o apoyos visuales junto al lenguaje oral; la lectura fácil en los materiales escritos; la división de tareas complejas en pasos verificables uno a uno; y el modelado, es decir, mostrar cómo se hace una tarea antes de pedir que se haga de forma autónoma.

Testimonio simulado — Noelia, 31 años, discapacidad intelectual leve:

"Cuando el profe explicaba algo nuevo, yo me perdía en la mitad. No porque no me interesara. Porque eran demasiadas cosas seguidas. Una profesora me empezó a dar las cosas escritas en pasos, con dibujos pequeños al lado. Y entonces sí. Entonces lo entendía igual que los demás. Lo que pasaba antes no es que yo no pudiera. Es que nadie me lo había dado de una forma que yo pudiera coger."

5.4 Cómo adaptar dinámicas grupales

Actividad original: debate abierto sobre un tema, con turnos espontáneos y argumentación libre.

Adaptación: entregar previamente al alumno con discapacidad intelectual una ficha con dos o tres frases ya elaboradas que pueda usar como punto de partida, y avisarle con antelación del turno en que va a participar.

Actividad original: examen tipo test con quince preguntas de opción múltiple con enunciados largos.

Adaptación: reformular los enunciados en lenguaje más directo, reducir el número de distractores por pregunta, y permitir más tiempo sin que eso se interprete como menor exigencia de contenido.

Actividad original: trabajo en grupo con roles asignados de forma implícita según quien tome la iniciativa.

Adaptación: asignar roles explícitos y concretos por escrito a cada miembro del grupo, de forma que la persona sepa exactamente qué se espera de ella sin tener que interpretarlo de la dinámica social del grupo.

5.5 Errores frecuentes

Tratar a un adulto con discapacidad intelectual con un tono o vocabulario infantilizado es uno de los errores más extendidos y más dañinos, porque transmite un mensaje de incapacidad global que no se corresponde con la realidad de la persona. Otro error habitual es asumir que la dificultad para expresarse verbalmente con fluidez equivale a dificultad para comprender: muchas personas comprenden mucho más de lo que pueden expresar de forma espontánea, y juzgar su comprensión por su expresión oral lleva a infravalorar sistemáticamente sus capacidades.

Tabla 5.1 — Discapacidad intelectual en contextos formativos

Aspecto	Manifestación frecuente	Estrategia recomendada
Instrucciones	Pérdida de información en instrucciones largas o encadenadas	Secuenciar en pasos cortos, verbos de acción concretos
Abstracción	Dificultad con conceptos no vinculados a la experiencia	Ejemplos concretos, apoyo visual, vinculación a la práctica
Generalización	No transferir aprendizajes a contextos nuevos sin enseñanza explícita	Practicar en distintos contextos de forma guiada
Expresión vs. comprensión	Comprensión mayor que la expresión verbal espontánea	No juzgar comprensión solo por fluidez oral
Ritmo	Necesidad de más repetición espaciada	Práctica distribuida, no masificada en una sola sesión
Instrucciones	Pérdida de información en instrucciones largas o encadenadas	Secuenciar en pasos cortos, verbos de acción concretos

CAPÍTULO 6: TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

6.1 Sobrecarga sensorial

El sistema nervioso de una persona con TEA procesa la información sensorial de forma distinta a la de una persona neurotípica. No se trata de mayor sensibilidad en el sentido coloquial del término, sino de un procesamiento que con frecuencia carece de los filtros automáticos que la mayoría de las personas usan sin ser conscientes de ello para descartar estímulos irrelevantes.

En un aula convencional conviven simultáneamente el zumbido del proyector, la luz fluorescente parpadeando a una frecuencia que la mayoría no percibe, el roce de las sillas, conversaciones de fondo, olores de productos de limpieza o de comida cercana, y la textura de los materiales que se manipulan. Una persona neurotípica filtra automáticamente la mayor parte de estos estímulos y atiende a la voz del docente. Una persona con TEA puede recibir todos estos estímulos con una intensidad similar, sin jerarquía automática entre ellos, lo que exige un esfuerzo consciente y agotador de filtrado que compite directamente con los recursos cognitivos necesarios para atender al contenido formativo.

Cuando la sobrecarga sensorial supera el umbral de tolerancia, puede producirse lo que se conoce como colapso sensorial (meltdown) o, en sentido contrario, un cierre o desconexión (shutdown). Ninguno de los dos es una rabieta ni un acto de desobediencia. Son respuestas neurológicas ante una saturación real del sistema.

6.2 Procesamiento social

La dificultad en el procesamiento social que caracteriza al TEA no es ausencia de empatía, como erróneamente se ha popularizado. Es una diferencia en la decodificación automática de las señales sociales implícitas: el tono de voz, la expresión facial sutil, el lenguaje corporal, el doble sentido, la ironía o el sarcasmo.

Una persona neurotípica interpreta automáticamente estas señales sin esfuerzo consciente. Una persona con TEA a menudo necesita procesarlas de forma deliberada y consciente, lo cual consume tiempo y energía, y puede llevar a interpretaciones literales de expresiones que no estaban pensadas para ser tomadas al pie de la letra. Si un docente dice «no tenemos todo el día» como expresión de impaciencia, una persona con TEA puede tomarlo literalmente y no entender el subtexto de urgencia que se pretendía comunicar.

Esta diferencia de procesamiento no implica menor inteligencia social en el sentido de comprensión de normas. De hecho, muchas personas con TEA aprenden las reglas sociales de forma explícita y consciente, casi como quien aprende un idioma extranjero mediante reglas gramaticales, en lugar de absorberlas de forma intuitiva.

6.3 Necesidad de estructura y ansiedad ante la incertidumbre

La necesidad de estructura en personas con TEA no es rigidez caprichosa. Es una estrategia adaptativa frente a un mundo que, debido a las particularidades del procesamiento sensorial y social descritas, resulta intrínsecamente más impredecible y más difícil de anticipar que para una persona neurotípica.

Cuando una persona sabe exactamente qué va a ocurrir, en qué orden y durante cuánto tiempo, puede dedicar sus recursos cognitivos al contenido del aprendizaje. Cuando no lo sabe, una parte significativa de esos recursos se destina a la vigilancia constante del entorno para anticipar cambios, lo cual genera un estado de ansiedad de fondo que interfiere directamente con la capacidad de concentración y aprendizaje.

Un cambio de última hora en el horario, una actividad no anunciada, un cambio de aula sin aviso previo o una alteración en el orden habitual de la sesión pueden generar en una persona con TEA un nivel de ansiedad desproporcionado respecto a lo que esa misma situación generaría en otra persona. No porque la persona «exagere», sino porque el cambio inesperado activa de forma genuina los sistemas de alerta del organismo.

Testimonio simulado — Daniel, 23 años, TEA nivel 1 de apoyo:

"Cuando me dan el horario de la semana, lo necesito de verdad. No es un capricho. Si un día cambian el orden de las clases sin avisar, paso el resto del día con un nudo en el estómago, intentando entender qué más puede cambiar sin que yo lo sepa. La gente piensa que me cuesta adaptarme. Lo que me cuesta es no saber. Si me lo dicen con antelación, me adapto sin ningún problema.."

6.4 Cómo diseñar clases predecibles

La predictibilidad no significa rigidez absoluta ni ausencia de variedad pedagógica. Significa que los cambios, cuando ocurren, se anuncian con antelación suficiente y de forma explícita.

Estrategias concretas: mostrar al inicio de cada sesión un esquema visual de lo que va a ocurrir y en qué orden; avisar con antelación de cualquier cambio respecto a la rutina habitual, explicando el motivo; utilizar señales claras y consistentes para marcar las transiciones entre actividades, evitando cambios bruscos sin aviso; ofrecer la posibilidad de anticipar las actividades de evaluación o las dinámicas grupales con tiempo suficiente para procesarlas; y mantener un lugar o forma de comunicación específica para que la persona pueda señalar, sin necesidad de exponerse verbalmente ante el grupo, que está alcanzando un nivel de sobrecarga.

Es igualmente importante distinguir entre rigidez y necesidad de previsión. No se trata de eliminar toda la flexibilidad pedagógica del aula, sino de comunicar los cambios de forma clara, en lugar de introducirlos sin aviso y esperar una adaptación instantánea.

Tabla 6.1 — TEA en contextos formativos

Aspecto	Manifestación frecuente	Estrategia recomendada
Sobrecarga sensorial	Dificultad para filtrar estímulos del entorno (luz, ruido, olores)	Reducir estímulos innecesarios, prever espacios de pausa sensorial
Procesamiento social	Dificultad para decodificar señales implícitas, ironía, dobles sentidos	Comunicación explícita y literal, evitar ambigüedad
Necesidad de estructura	Ansiedad ante cambios no anunciados	Horario visual, anticipación de cambios, rutinas claras
Transiciones	Dificultad en cambios bruscos entre actividades	Señales claras de transición, aviso previo
Comunicación de sobrecarga	Dificultad para pedir ayuda verbalmente en el momento	Sistema de señal no verbal pactado de antemano
Sobrecarga sensorial	Dificultad para filtrar estímulos del entorno (luz, ruido, olores)	Reducir estímulos innecesarios, prever espacios de pausa sensorial

CAPÍTULO 7: TDAH Y OTRAS DIFICULTADES DE ATENCIÓN

7.1 Cómo funciona el sistema ejecutivo en el TDAH

El TDAH no es un déficit de atención en el sentido literal del término. Las personas con TDAH no carecen de capacidad de atención: pueden concentrarse durante horas en una actividad que les resulta altamente estimulante o significativa. Lo que presentan es una dificultad en la regulación voluntaria de la atención, es decir, en dirigirla y sostenerla hacia lo que el entorno externo demanda, independientemente del nivel de interés que eso genere.

La base neurobiológica está bien documentada: el TDAH implica diferencias en el funcionamiento de los circuitos prefrontales y en la disponibilidad de dopamina y noradrenalina, dos neurotransmisores centrales para la regulación de la atención, la planificación, la inhibición de impulsos y la memoria de trabajo. No es falta de voluntad. No es mala educación. Es una arquitectura neurológica distinta que produce un perfil funcional específico.

Las funciones ejecutivas afectadas con mayor frecuencia en el TDAH incluyen: memoria de trabajo (capacidad de retener información mientras se trabaja con ella), inhibición de respuestas impulsivas, planificación y organización de tareas complejas, gestión del tiempo, flexibilidad cognitiva, y regulación emocional. La afectación no es uniforme en todas las personas con TDAH, y puede variar significativamente en función del contexto, el nivel de interés, la hora del día o el nivel de fatiga.

7.2 Lo que ocurre en el aula

Una sesión formativa convencional está diseñada, en gran medida, de una forma que maximiza las dificultades de una persona con TDAH: bloques largos de escucha pasiva, tareas con recompensa diferida y poco estímulo inmediato, instrucciones múltiples encadenadas, y entornos con numerosos distractores visuales y auditivos que el docente no percibe porque su propio sistema los filtra automáticamente.

Para una persona con TDAH, el ronroneo del proyector, el movimiento de un compañero al otro lado del aula, la conversación que se filtra desde el pasillo o el patrón del techo son estímulos que compiten en tiempo real con la voz del docente por los recursos atencionales disponibles. No por elección, sino porque el sistema de filtrado selectivo no opera con la misma eficiencia que en una persona neurotípica.

La memoria de trabajo reducida tiene una consecuencia práctica muy concreta: si el docente da una instrucción de cuatro pasos y entre el segundo y el cuarto paso hay cualquier distracción, es probable que los pasos intermedios se pierdan. La persona no estaba «despistada». Estaba procesando, pero la capacidad de retención en paralelo se saturó.

7.3 La fatiga de la atención

La fatiga de la atención en el TDAH es un fenómeno real y diferente a la fatiga ordinaria. Mantener la atención de forma voluntaria en una tarea de baja estimulación tiene un coste energético superior al que tiene para una persona neurotípica. Esto significa que, pasada cierta cantidad de tiempo, la capacidad de regulación atencional se agota aunque la persona haya dormido bien, esté motivada y quiera rendir.

Las consecuencias observables de la fatiga atencional no son siempre las que los docentes esperan. No siempre se manifiesta como somnolencia o pasividad. En muchos casos se manifiesta como aumento de la impulsividad, mayor dificultad para inhibir respuestas verbales, movimiento incrementado, o irritabilidad. Interpretar estas señales como falta de respeto o mal comportamiento es un error frecuente con consecuencias negativas sobre la relación pedagógica.

7.4 Estrategias prácticas para docentes

Estructurar el tiempo en bloques cortos. Las sesiones largas de escucha pasiva son el formato menos adecuado para alumnos con TDAH. Dividir la sesión en bloques de 15 a 20 minutos con una actividad diferente entre cada uno reduce la fatiga atencional y permite recuperar la concentración periódicamente. Esto beneficia al conjunto del grupo, no solo a quien tiene TDAH.

Incorporar movimiento de forma planificada. El movimiento físico activa los sistemas dopaminérgicos y mejora temporalmente la capacidad de atención. No es distracción: es regulación. Actividades que impliquen levantarse, reorganizar el espacio, manipular materiales o trabajar en distintos puntos del aula son herramientas pedagógicas legítimas y eficaces para alumnado con TDAH.

Dar instrucciones en pasos separados y verificables. En lugar de encadenar cuatro pasos de una vez, dar el primero, comprobar que se ha iniciado, dar el segundo. Si es necesario dar todos los pasos a la vez, hacerlo también por escrito en un lugar visible durante toda la actividad.

Reducir los distractores del entorno cuando sea posible. Esto no significa convertir el aula en una sala de examen permanente. Significa prestar atención a elementos del entorno que pueden estar generando competencia atencional innecesaria: notificaciones sonoras de dispositivos, materiales acumulados en las mesas, movimiento constante en el campo visual del alumno.

Ofrecer retroalimentación frecuente y específica. El sistema de recompensa en el TDAH responde especialmente bien a la retroalimentación inmediata. Una persona con TDAH que sabe en tiempo real si lo está haciendo bien puede mantener la motivación y la dirección de la tarea de forma mucho más efectiva que si solo recibe retroalimentación al final del proceso.

Pactar estrategias de autorregulación. Muchas personas con TDAH han desarrollado estrategias propias de regulación que funcionan para ellas: tomar notas como ancla atencional aunque no las vayan a releer, usar objetos de manipulación discreta en las manos, colocarse en determinada posición en el aula. Preguntar a la persona qué estrategias le ayudan, en lugar de prohibir conductas que pueden ser en realidad mecanismos funcionales de regulación, es mucho más eficaz que imponer una norma de quietud que no tiene en cuenta la neurobiología de la persona.

7.5 El TDAH en adultos

El TDAH en adultos tiene con frecuencia un perfil distinto al del TDAH en niños y adolescentes, y es menos reconocido, lo que lleva a que muchos adultos lleguen a contextos formativos con un diagnóstico tardío o sin diagnóstico. En adultos, la hiperactividad motora visible es menos frecuente, sustituida a menudo por una hiperactividad interna: pensamientos acelerados, dificultad para «desconectar», sensación constante de que hay que estar haciendo algo. La impulsividad puede manifestarse más en el plano verbal o en la toma de decisiones que en el movimiento físico.

La persona adulta con TDAH ha acumulado frecuentemente años de experiencias de fracaso, reprimendas y sensación de no estar a la altura en contextos en los que otras personas parecían esforzarse menos para obtener los mismos resultados. Esto tiene un impacto directo en la autoestima, en la resistencia a pedir ayuda y en la relación con los entornos de aprendizaje formales.

Tabla 7.1 — TDAH en contextos formativos

Aspecto	Manifestación frecuente	Interpretación errónea habitual	Estrategia recomendada
Atención	Pérdida de hilo en sesiones largas	"No presta atención porque no quiere"	Bloques cortos, actividad variada
Memoria de trabajo	Pérdida de pasos intermedios en instrucciones	"No hace caso a lo que se le dice"	Instrucciones secuenciadas, soporte escrito
Impulsividad	Respuestas verbales sin esperar turno	"Es maleducado o irrespetuoso"	Estructura de turno explícita, retroalimentación inmediata
Movimiento	Dificultad para permanecer quieto períodos largos	"Está nervioso o no tiene interés"	Incorporar movimiento planificado en la sesión
Fatiga atencional	Irritabilidad o desconexión en la segunda mitad de la sesión	"Cuando se cansa, se desentiende"	Pausas activas, cambio de formato a mitad de sesión
Desorganización	Dificultad para gestionar plazos y materiales	"Es irresponsable"	Apoyos externos de organización, recordatorios, listas

CAPÍTULO 8: DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL

8.1 Qué es la discapacidad psicosocial

La discapacidad psicosocial es el resultado de la interacción entre una condición de salud mental y las barreras del entorno que impiden la participación plena de la persona en la vida educativa, laboral y social. El diagnóstico psiquiátrico no determina por sí solo la discapacidad. La determina la combinación entre los efectos funcionales de ese diagnóstico y la respuesta del entorno ante ellos.

Esta distinción es fundamental en la práctica formativa porque significa que el mismo diagnóstico puede generar una discapacidad significativa en un entorno rígido, exigente y poco comprensivo, y prácticamente ninguna en un entorno flexible, predecible y seguro. El docente, en este contexto, no es un espectador neutral: es una variable activa en el nivel de discapacidad que experimenta la persona.

Las condiciones de salud mental que con mayor frecuencia generan situaciones de discapacidad psicosocial en contextos formativos incluyen los trastornos de ansiedad, la depresión mayor, el trastorno bipolar y las psicosis estabilizadas, entre ellas la esquizofrenia. Cada una tiene un perfil funcional distinto, con implicaciones diferentes para el aprendizaje y la participación.

8.2 Trastornos de ansiedad

La ansiedad en su expresión clínica no es nerviosismo ordinario. Es un estado de activación fisiológica del sistema nervioso autónomo que produce, entre otros efectos, aumento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular, dificultad respiratoria, hipervigilancia cognitiva y, en los casos más intensos, la percepción de amenaza inminente sin que exista un peligro objetivo real.

En un contexto formativo, la ansiedad puede manifestarse de formas que el docente no siempre identifica como tales. Una persona con trastorno de ansiedad generalizada puede presentar dificultad para concentrarse porque su sistema cognitivo está parcialmente ocupado en la monitorización constante de posibles amenazas. Una persona con fobia social puede evitar intervenir en clase, no por desinterés o timidez ordinaria, sino porque la anticipación de la exposición pública activa una respuesta de amenaza genuina. Una persona con trastorno de pánico puede necesitar tener clara la ubicación de la salida del aula, saber que puede salir sin pedir permiso explícito si lo necesita, y conocer con antelación el formato de las actividades.

La ansiedad de rendimiento merece mención específica porque es especialmente prevalente en contextos formativos y puede afectar a personas sin diagnóstico previo o con diagnóstico no comunicado. Se caracteriza por una activación intensa ante situaciones de evaluación que deteriora el rendimiento de forma desproporcionada respecto a la competencia real de la persona. Un alumno que domina el contenido puede obtener resultados muy por debajo de su

nivel real en un examen convencional debido a la interferencia de la ansiedad sobre la memoria de recuperación y el procesamiento cognitivo.

8.3 Depresión mayor

La depresión mayor no es tristeza prolongada. Es una alteración neurobiológica que afecta de forma directa a la energía disponible, la capacidad de concentración, la motivación, la memoria y la velocidad de procesamiento cognitivo. Una persona en fase depresiva activa puede tener dificultades reales para leer un párrafo y retener su contenido, para mantener la atención durante más de pocos minutos, o para iniciar una tarea aunque sepa exactamente cómo hacerla.

La abulia, es decir, la ausencia de voluntad o iniciativa, es uno de los síntomas más incomprensidos de la depresión en contextos formativos. Desde fuera puede parecer pasividad, desmotivación o falta de compromiso. Desde dentro es la experiencia de querer hacer algo y no poder acceder a los recursos internos para iniciarlo, como si entre la intención y la acción hubiera un muro transparente.

La variabilidad sintomática es otra característica que el docente debe conocer. La depresión mayor, especialmente cuando está en tratamiento, puede presentar días de funcionamiento relativamente normal alternados con días de funcionamiento muy limitado. Esta variabilidad no es fingimiento ni estrategia. Es la naturaleza de la condición.

Testimonio simulado — Lucía, 35 años, depresión mayor recurrente en tratamiento:

"Había días que llegaba al aula y podía seguir la clase con normalidad. Otros días me sentaba y el docente hablaba y yo escuchaba los sonidos pero no llegaban a formar frases con sentido. Intentaba leer y tenía que volver al principio del párrafo cuatro o cinco veces. Desde fuera parecía que estaba mirando al vacío. Por dentro estaba haciendo un esfuerzo enorme solo para estar sentada ahí. Lo que más me ayudó fue que un docente me dijo en privado que si había días que necesitaba salir un momento, podía hacerlo sin dar explicaciones."

8.4 Trastorno bipolar

El trastorno bipolar se caracteriza por la alternancia entre fases depresivas y fases de manía o hipomanía, con períodos de estabilidad entre ellas. En los contextos formativos, la persona con trastorno bipolar bien tratado puede funcionar con plena normalidad durante las fases estables, que pueden ser prolongadas. Las dificultades aparecen principalmente en las transiciones de fase, que no siempre son predecibles ni controlables de forma voluntaria.

Durante una fase hipomaniaca leve, la persona puede parecer especialmente activa, creativa y participativa. Puede intervenir más de lo habitual, tener más iniciativa y mostrar mayor energía. Lo que no es visible es que esa activación puede estar acompañada de reducción del sueño, pensamiento acelerado y dificultad para filtrar ideas, lo que interfiere con la concentración sostenida y la organización del trabajo.

Durante una fase depresiva, se aplican las mismas consideraciones descritas en el apartado anterior. La persona puede tener dificultades de concentración, iniciativa reducida y fatiga cognitiva intensa.

Lo que el docente puede hacer en la práctica es, fundamentalmente, mantener una actitud de disponibilidad sin intrusión: hacer saber a la persona que puede comunicar sus necesidades en cualquier momento, sin exigir explicaciones sobre sus fluctuaciones de rendimiento, y ofrecer flexibilidad en plazos y formatos cuando la situación lo requiera.

8.5 Esquizofrenia estabilizada

La esquizofrenia en fase estable, con tratamiento adecuado y seguimiento, es compatible con la participación en procesos formativos y con la inserción laboral. Este punto merece subrayarse porque el estigma asociado a la esquizofrenia es posiblemente el más intenso de todos los relacionados con condiciones de salud mental, y produce con frecuencia exclusiones injustificadas basadas en el diagnóstico y no en la situación funcional real de la persona.

Una persona con esquizofrenia estabilizada puede presentar algunos efectos secundarios de la medicación que afectan al rendimiento en el aula: sedación diurna, enlentecimiento cognitivo, dificultad de concentración o fatiga. Estos efectos no son síntomas de la enfermedad sino consecuencias del tratamiento, y pueden gestionarse con adaptaciones de horario, reducción de la carga en determinados momentos, o ajuste del ritmo de la sesión.

Las señales que pueden indicar una descompensación incipiente incluyen cambios en el comportamiento habitual, retraimiento brusco, dificultad para seguir conversaciones que antes se seguían con normalidad, o expresión de preocupaciones inusuales. Ante estas señales, el docente no debe actuar como clínico ni intentar evaluar el estado mental de la persona, sino activar el protocolo de apoyo disponible en el centro y asegurarse de que la persona tiene acceso a su red de apoyo profesional.

8.6 Cómo generar un entorno seguro

La seguridad psicológica en el aula es la condición que permite a una persona participar, equivocarse, preguntar y pedir ayuda sin temor a consecuencias negativas sobre su imagen o su relación con el grupo y el docente. Para las personas con discapacidad psicosocial, esta seguridad no es un elemento accesorio del clima de aula: es una condición necesaria para que el aprendizaje sea posible.

Predecibilidad. Las personas con ansiedad o con condiciones que afectan a la regulación emocional se benefician especialmente de entornos predecibles. Comunicar con antelación los cambios, mantener una estructura consistente de sesión y evitar sorpresas innecesarias reduce la carga de vigilancia que el sistema nervioso dedica a anticipar amenazas.

Confidencialidad real. Si un alumno comparte información sobre su condición de salud mental, esa información no debe circular entre el equipo docente sin el consentimiento expreso de la persona. La quiebra de confidencialidad, incluso con buena intención, destruye la confianza y elimina la posibilidad de comunicación futura.

Ausencia de exposición no consentida. Llamar a alguien a responder en voz alta delante del grupo cuando esa persona no ha levantado la mano, o proponer actividades que requieren exposición pública sin haberlas anunciado con antelación, puede ser una fuente de activación de ansiedad intensa. El docente que tiene en cuenta esto no está bajando el nivel de exigencia: está eliminando una barrera que no tiene ninguna relación con el contenido formativo.

Normalización del apoyo. Que pedir ayuda, solicitar una adaptación o salir un momento del aula sea algo normal en la dinámica del grupo reduce el estigma y facilita que las personas que lo necesitan lo hagan sin sentir que están señalándose a sí mismas.

Lenguaje no estigmatizante. Evitar expresiones como «está loco», «tiene un brote», «es un esquizofrénico» o «los bipolares son impredecibles» en cualquier contexto del aula. El lenguaje que el docente usa en el aula modela el lenguaje y las actitudes del grupo

Tabla 8.1 — Discapacidad psicosocial en contextos formativos

Aspecto	Manifestación frecuente	Interpretación errónea habitual	Estrategia recomendada
Ansiedad generalizada	Dificultad de concentración, evitación de participación	"No se esfuerza, es tímido"	Anticipar actividades, no forzar exposición pública, ambiente predecible
Fobia social	Evitación de intervenciones en grupo, ausencias antes de evaluaciones	"No le interesa, pasa de todo"	Alternativas a la exposición grupal, evaluación en formatos menos expuestos
Depresión mayor	Abulia, lentitud cognitiva, variabilidad de rendimiento	"Un día puede y otro no quiere"	Flexibilidad en plazos, salidas sin explicación, apoyo sin intrusión
Trastorno bipolar	Fluctuaciones de energía y participación entre sesiones	"Es inconsistente e impredecible"	Aceptar la variabilidad, flexibilidad sin exigir justificación diagnóstica
Esquizofrenia estabilizada	Sedación, enlentecimiento, retraimiento ocasional	"No puede seguir un proceso formativo"	Adaptar ritmo y horario, activar red de apoyo ante señales de descompensación

CAPÍTULO 9: DISCAPACIDADES MÚLTIPLES E INVISIBLES

9.1 El problema de la invisibilidad

Hay discapacidades que no se ven. No hay silla de ruedas, no hay audífono, no hay ningún elemento externo que señale al entorno que esa persona tiene una condición que afecta a su funcionamiento cotidiano. Y precisamente por eso, las barreras que generan son especialmente difíciles de gestionar: porque el entorno no las reconoce, porque los profesionales las cuestionan, y porque la persona lleva años escuchando que parece perfectamente bien.

La invisibilidad de una discapacidad no reduce su impacto funcional. Lo que reduce es la probabilidad de que el entorno ofrezca los apoyos necesarios, porque el primer requisito para ofrecer un apoyo es reconocer que hay una necesidad. Cuando la necesidad no es visible, el reconocimiento depende casi exclusivamente de que la persona la comunique, lo cual exige un nivel de confianza en el entorno y una seguridad psicológica que con frecuencia no existen.

Las discapacidades invisibles comparten además una característica que las hace especialmente complejas en contextos formativos: la variabilidad. No se expresan igual cada día, ni cada semana, ni en cada contexto. Un día la persona puede participar con aparente normalidad. Otro día, con el mismo diagnóstico y el mismo entorno, puede ser incapaz de sostener la concentración durante más de diez minutos. Esta variabilidad, que es la naturaleza real de muchas de estas condiciones, se interpreta con frecuencia como inconsistencia, falta de esfuerzo o manipulación.

9.2 Fibromialgia

La fibromialgia es una condición de dolor musculoesquelético crónico generalizado, acompañada de fatiga, alteraciones del sueño, dificultades cognitivas y, en muchos casos, un estado de activación del sistema nervioso que hace que estímulos normalmente no dolorosos sean percibidos como dolorosos. No tiene marcador biológico visible en las pruebas estándar, lo que ha llevado a décadas de cuestionamiento de su legitimidad como condición real.

En el aula, una persona con fibromialgia puede presentar dificultades para mantenerse sentada en una misma postura durante períodos prolongados, fatiga que no guarda relación con la actividad realizada, y lo que se conoce coloquialmente como «niebla mental» o fibrofog: una dificultad real para recuperar palabras, mantener el hilo de una argumentación compleja o procesar información nueva a ritmo normal. Esta dificultad cognitiva no es subjetiva. Tiene correlatos neurobiológicos documentados en estudios de neuroimagen que muestran alteraciones en el procesamiento prefrontal.

Lo que el docente percibe puede ser: una persona que se mueve con incomodidad en la silla, que parece dudar al expresarse, que necesita que se le repita la información, y que tiene un rendimiento marcadamente variable entre sesiones. Lo que no percibe es el nivel de dolor de fondo que esa persona gestiona de forma constante mientras intenta participar.

Testimonio simulado — Carmen, 47 años, fibromialgia diagnosticada hace seis años:

"El día que mejor estoy en el aula es el día que nadie sabe que tengo fibromialgia. El día que peor estoy es el día que alguien dice, con buena intención, que no parezco enferma. Ese comentario me dice que si al día siguiente no puedo venir o no puedo concentrarme, nadie lo va a entender. Prefiero que sepan que hay días buenos y días malos, y que los días malos no son excusa: son la condición."

9.3 Síndrome de fatiga crónica

El Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), también denominado Encefalomiелitis Miálgica (EM), es una condición caracterizada por una fatiga profunda y debilitante que no mejora con el descanso y que se agrava de forma significativa con el esfuerzo físico o cognitivo. Este agravamiento posterior al esfuerzo, denominado malestar post-esfuerzo, es el síntoma más específico de la condición y el más incomprendido en los entornos formativos.

El malestar post-esfuerzo significa que la consecuencia de un día de actividad intensa no es cansancio que se resuelve con una noche de sueño. Puede ser un período de dos o tres días de funcionamiento significativamente reducido, con síntomas que incluyen dolor, dificultad cognitiva severa, sensibilidad aumentada a los estímulos y, en los casos más graves, incapacidad de realizar actividades básicas.

Para el docente, esto implica una consideración contraintuitiva: presionar a una persona con SFC para que rinda más en un día en que puede hacerlo puede tener consecuencias negativas sobre su capacidad de funcionamiento en los días siguientes. La gestión del ritmo de actividad no es una estrategia de evitación. Es una necesidad fisiológica real.

Las adaptaciones más relevantes en contextos formativos incluyen: flexibilidad en la asistencia y en los plazos; posibilidad de acceder a los materiales de la sesión de forma asincrónica cuando la asistencia presencial no es posible; reducción de la carga en períodos de mayor sintomatología; y ausencia de exigencia de justificación médica continua para cada adaptación.

9.4 Enfermedades raras

Se considera enfermedad rara aquella que afecta a menos de cinco personas por cada diez mil habitantes. En España están catalogadas más de tres mil enfermedades raras, y aunque individualmente cada una tiene una prevalencia baja, en conjunto afectan a entre el 6 y el 8% de la población a lo largo de la vida.

Las enfermedades raras plantean un desafío específico en los contextos formativos: el docente raramente las conoce. A diferencia de la discapacidad visual o la parálisis cerebral,

que forman parte del imaginario colectivo aunque sea de forma imprecisa, una condición como el síndrome de Ehlers-Danlos, la ataxia de Friedreich o la esclerosis lateral amiotrófica en estadio inicial puede ser completamente desconocida para el profesional que trabaja con la persona.

Esto exige una actitud de apertura y de aprendizaje activo. Cuando un alumno comunica que tiene una enfermedad rara, la respuesta adecuada no es fingir que se conoce ni minimizar su impacto por desconocimiento. Es preguntar directamente a la persona qué implicaciones tiene en el contexto formativo específico, qué adaptaciones necesita y cuáles son las señales que indican que necesita apoyo.

FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) es el organismo de referencia en España y dispone de recursos específicos para docentes y entornos educativos.

9.5 Daño cerebral adquirido

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es el resultado de una lesión cerebral que se produce de forma súbita después del nacimiento, por causas como el ictus, el traumatismo craneoencefálico, la anoxia cerebral o los tumores cerebrales. A diferencia de las condiciones congénitas o del neurodesarrollo, el DCA implica un «antes» y un «después» que la propia persona experimenta de forma consciente.

El perfil funcional resultante del DCA depende de la localización y la extensión de la lesión, y puede incluir combinaciones muy variables de: dificultades motoras, alteraciones del habla y el lenguaje, problemas de memoria —especialmente memoria a corto plazo y memoria de trabajo—, dificultades de atención sostenida y selectiva, lentitud de procesamiento cognitivo, dificultades en las funciones ejecutivas, cambios en la regulación emocional, y fatiga cognitiva intensa.

Un elemento que distingue al DCA de otras condiciones en el contexto formativo es el impacto identitario. La persona que ha sufrido un ictus o un traumatismo grave conoce cómo funcionaba antes. Tiene una referencia interna de lo que era capaz de hacer y experimenta de forma directa la diferencia. Esto puede generar un duelo por las capacidades perdidas que se superpone a las dificultades funcionales y que requiere un abordaje específico que va más allá de las adaptaciones metodológicas.

La lentitud de procesamiento en el DCA no es pereza ni distracción. Es el resultado de que las señales neuronales tardan más en recorrer los circuitos dañados o los circuitos alternativos que el cerebro ha construido como compensación. Dar más tiempo para las respuestas, para las evaluaciones y para la realización de tareas no es una concesión: es la adaptación que permite que el nivel real de comprensión sea medible.

9.6 Enfermedades degenerativas

Las enfermedades degenerativas, como la esclerosis múltiple en estadios avanzados, la enfermedad de Parkinson o las enfermedades de motoneurona, presentan un perfil de discapacidad que evoluciona en el tiempo. Esto introduce una variable que los contextos formativos raramente contemplan: la persona que empieza un proceso formativo puede tener un nivel funcional distinto al que tiene al finalizarlo, y ese cambio puede ocurrir en cualquier dirección y con cualquier velocidad.

El docente que trabaja con una persona con una enfermedad degenerativa necesita comprender que las adaptaciones acordadas al inicio del proceso pueden necesitar revisión periódica, y que un deterioro en el rendimiento no indica necesariamente menor esfuerzo o menor compromiso, sino que puede reflejar una evolución de la condición de base. La comunicación abierta y regular con la persona, sin presuponer lo que está ocurriendo, es el principio más importante en este contexto.

9.7 Discapacidades múltiples

La discapacidad múltiple no es la suma aritmética de varias discapacidades. Es una configuración funcional compleja en la que las distintas condiciones interactúan entre sí de formas que no siempre son predecibles. Una persona con discapacidad intelectual y discapacidad motora no tiene las necesidades de una persona con discapacidad intelectual más las necesidades de una persona con discapacidad motora. Tiene un perfil propio que requiere un análisis específico.

En los contextos formativos, la discapacidad múltiple exige una evaluación individualizada que parta de las capacidades de la persona, no de sus diagnósticos, y que diseñe el itinerario formativo desde ese punto. Ninguna combinación de diagnósticos determina por adelantado el techo de aprendizaje de una persona. Lo que determina el techo es la calidad del entorno de aprendizaje y la calidad del apoyo disponible.

Tabla 9.1 — Discapacidades invisibles y múltiples en contextos formativos

Aspecto	Manifestación frecuente en el aula	Interpretación errónea habitual	Estrategia recomendada
Fibromialgia	Dolor postural, niebla mental, variabilidad de rendimiento	"Exagera o busca excusas"	Flexibilidad postural, ritmo adaptado, validar la variabilidad
Síndrome de fatiga crónica	Agotamiento desproporcionado, malestar post-esfuerzo	"No se esfuerza lo suficiente"	No presionar en días de mayor capacidad, acceso asincrónico
Enfermedad rara	Perfil funcional desconocido para el docente	"No sé qué tiene, así que no sé qué hacer"	Preguntar directamente a la persona, buscar información en FEDER
Daño cerebral adquirido	Lentitud de procesamiento, fatiga cognitiva, variabilidad	"Antes podía y ahora no quiere"	Más tiempo, pasos explícitos, reconocer el impacto identitario
Enfermedad degenerativa	Evolución del perfil funcional a lo largo del proceso	"Ha empeorado porque no se cuida"	Revisión periódica de adaptaciones, comunicación abierta
Discapacidad múltiple	Perfil complejo no reducible a diagnósticos individuales	Aplicar recetas de un solo diagnóstico	Evaluación individualizada desde las capacidades reales

CAPÍTULO 10: COMUNICACIÓN INCLUSIVA

10.1 ¿Por qué importa el lenguaje?

El lenguaje no es un medio neutro de transmisión de información. Es el entorno en el que ocurre el aprendizaje. La forma en que un docente da instrucciones, formula preguntas, corrige errores o gestiona conflictos determina si una persona con discapacidad puede participar en condiciones de igualdad o si, por el contrario, el propio acto comunicativo se convierte en una barrera adicional.

La comunicación inclusiva no es eufemismo ni condescendencia. No consiste en evitar palabras difíciles ni en simplificar el contenido hasta vaciarlo de significado. Consiste en diseñar los intercambios comunicativos de forma que sean accesibles para la mayor diversidad posible de personas sin sacrificar la precisión técnica ni el nivel de exigencia.

Hay una diferencia fundamental entre adaptar el canal de comunicación y reducir el contenido. Un docente que explica un concepto complejo usando un ejemplo concreto antes de la definición abstracta no está empobreciendo el contenido: está abriendo el acceso a ese contenido a personas que procesan mejor de lo concreto a lo abstracto. El concepto sigue siendo exactamente el mismo.

10.2 ¿Cómo dar instrucciones?

Las instrucciones son el elemento comunicativo que con mayor frecuencia genera barreras en contextos formativos, porque los docentes tienden a darlas de la forma en que ellos mismos las procesarían, no de la forma en que las procesará la persona con mayores dificultades de comprensión o de memoria de trabajo.

Principios para instrucciones accesibles:

Una acción por instrucción. Evitar encadenar varias acciones en una sola frase. «Leed el texto, subrayad las ideas principales, resumidlas en tres frases y preparad una pregunta para el debate» son cuatro instrucciones. Dadas como una sola unidad, quien tenga dificultades de memoria de trabajo perderá los pasos intermedios de forma inevitable.

Verbos de acción concretos. Sustituir verbos vagos por verbos que describan una acción observable. «Trabajad el tema» no es una instrucción. «Abrid el manual por la página veinte» sí lo es.

Soporte visual de las instrucciones orales. Escribir en la pizarra o proyectar los pasos de la tarea mientras se explican oralmente. Esto no es redundante: es accesibilidad para personas con procesamiento auditivo alterado, memoria de trabajo reducida o dificultades de atención sostenida.

Verificar la comprensión antes de iniciar. No preguntar «¿lo habéis entendido?» porque la respuesta automática es sí aunque no sea así. Preguntar en cambio «¿alguien puede decirme cuál es el primer paso?» o «¿qué tenéis que hacer cuando terminéis el punto dos?». La verificación activa de la comprensión es incomparablemente más informativa que la pregunta retórica.

Demostrar antes de pedir. El modelado, es decir, mostrar cómo se realiza la tarea antes de pedirla, es la estrategia de mayor impacto para personas con discapacidad intelectual, con TDAH o con dificultades de procesamiento. Ver cómo se hace activa más vías de comprensión que escuchar cómo se describe.

10.3 ¿Cómo formular preguntas?

La forma en que se formulan las preguntas en el aula puede incluir o excluir a personas con distintos perfiles de procesamiento. Las preguntas abiertas y ambiguas favorecen a quienes tienen mayor fluidez verbal espontánea. Las preguntas muy cerradas favorecen a quienes necesitan estructura para responder. El docente inclusivo diversifica.

Preguntas con tiempo de procesamiento. Después de lanzar una pregunta al grupo, esperar al menos diez segundos antes de llamar a alguien o responder. Este silencio, que a muchos docentes les resulta incómodo, es el tiempo que necesitan las personas con procesamiento más lento para formular una respuesta. La práctica de lanzar la pregunta, contar mentalmente hasta diez y solo entonces solicitar una respuesta cambia radicalmente quién puede participar.

Preguntas anticipadas. Para personas con ansiedad social, con TEA o con discapacidad intelectual, saber con antelación que se les va a hacer una pregunta específica permite procesarla y preparar la respuesta sin la presión del tiempo real. Comunicar en privado «en la sesión de mañana te voy a preguntar sobre el apartado tres» no es trampa: es accesibilidad.

Reformulación sin penalización. Si una persona no comprende la pregunta, reformularla de forma diferente, no repetirla más alto. La repetición de la misma formulación a mayor volumen no resuelve el problema de comprensión; lo señala socialmente y genera vergüenza.

Preguntas de elección en lugar de preguntas de recuerdo libre. Para personas con dificultades de recuperación de información, una pregunta del tipo «¿fue A o B lo que causó el problema?» es más accesible que «¿qué causó el problema?» sin que el nivel de comprensión que se evalúa sea necesariamente distinto.

10.4 ¿Cómo corregir errores?

La corrección de errores es el momento de mayor vulnerabilidad comunicativa en el aula para muchas personas con discapacidad. El error, en sí mismo, es información pedagógica valiosa. El problema es cómo se gestiona ese momento, porque las consecuencias de una corrección mal gestionada van mucho más allá del error concreto: afectan a la disposición a participar en el futuro, a la autoestima académica y a la relación con el docente.

Separar el error de la persona. «Esa respuesta no es correcta» es muy diferente de «te has equivocado». La primera señala el contenido. La segunda señala a la persona.

Encontrar lo aprovechable en la respuesta incorrecta. Con frecuencia una respuesta errónea contiene una parte correcta o revela un razonamiento que tiene lógica interna aunque conduzca a una conclusión equivocada. Señalar eso antes de corregir el error reduce la sensación de fracaso total y mantiene la motivación para seguir intentándolo.

No corregir públicamente de forma reiterada a la misma persona. Si un alumno comete errores con frecuencia, la corrección sistemática y pública convierte cada intervención en una oportunidad de exposición al fracaso. La corrección privada, o la reformulación que incluye la respuesta correcta sin señalar el error de forma explícita, puede ser más efectiva pedagógicamente y mucho menos dañina relacionalmente.

Normalizar el error como parte del aprendizaje. Si el docente modela la posibilidad de equivocarse, si reconoce sus propios errores de forma natural y sin dramatismo, si el aula es un entorno en el que equivocarse no tiene consecuencias negativas sobre la imagen de la persona, la disposición a participar aumenta para todo el grupo y especialmente para quienes tienen mayor miedo al fracaso.

10.5 ¿Cómo gestionar conflictos?

Los conflictos en el aula que implican a personas con discapacidad tienen con frecuencia una capa adicional de complejidad: la conducta que genera el conflicto puede ser el resultado de una necesidad no cubierta, de una barrera no resuelta o de una estrategia de regulación que el entorno no comprende.

Una persona con TEA que se niega a participar en una dinámica grupal no está siendo obstruccionista: probablemente está gestionando una sobrecarga sensorial o una ansiedad real ante una situación socialmente impredecible. Una persona con TDAH que interrumpe repetidamente no está faltando al respeto de forma deliberada: probablemente tiene dificultades genuinas para inhibir la respuesta impulsiva. Una persona con discapacidad psicosocial que reacciona de forma desproporcionada ante una corrección no está siendo dramática: probablemente está respondiendo desde un sistema nervioso ya activado por una carga acumulada que el docente no conoce.

Esto no significa que cualquier conducta sea aceptable o que no deba gestionarse. Significa que la gestión debe partir de la comprensión de la causa antes de la respuesta a la conducta.

Gestión en privado. Los conflictos que implican a una persona con discapacidad deben gestionarse, en la medida de lo posible, fuera del espacio grupal. La exposición pública de un conflicto añade una capa de vergüenza que complica la resolución y daña la relación pedagógica.

Pregunta antes que afirmación. En lugar de «estás interrumpiendo constantemente y eso no es aceptable», probar con «noto que estás teniendo dificultades para esperar el turno. ¿Hay algo que te esté resultando difícil en este momento?». La segunda formulación abre posibilidades. La primera cierra.

Acordar señales previas. Para personas con dificultades de regulación conocidas, acordar de forma proactiva señales o estrategias para antes de que el conflicto ocurra es mucho más efectivo que gestionarlo cuando ya ha ocurrido.

10.6 Lenguaje centrado en la persona

El lenguaje que el docente usa en el aula, tanto para dirigirse a las personas como para hablar sobre discapacidad, modela las actitudes del grupo y el nivel de seguridad psicológica que sienten las personas con discapacidad.

Tabla 10.1 — Frases recomendadas y frases a evitar

Evitar	Usar en su lugar	Por qué importa
"El discapacitado" / "La ciega"	"La persona con discapacidad" / "La persona con discapacidad visual"	Sitúa la persona antes que el diagnóstico
"Sufre de autismo" / "Padece TDAH"	"Tiene autismo" / "Tiene TDAH"	Evita el marco de sufrimiento inherente
"Es normal para alguien como él"	"Es una respuesta comprensible dado el contexto"	Evita la categorización por diagnóstico
"¿Lo has entendido?" (al repetir)	"¿Te ayudaría que lo formulara de otra manera?"	Sitúa la responsabilidad en el canal, no en la persona
"No te preocupes, tú no tienes que hacer eso"	"Podemos buscar una forma en que puedas participar"	Evita la exclusión bajo apariencia de protección
"Estos alumnos necesitan..."	"Esta persona necesita..."	Evita la homogeneización del colectivo
"Es que tiene un problema"	"Está encontrando una dificultad en este aspecto"	Distingue dificultad situacional de déficit permanente
"Muy bien, para lo que puedes hacer"	"Muy bien"	Elimina la condescendencia implícita en la comparación
"¿Puedes hacer esto tú solo?"	"¿Qué necesitas para poder hacerlo?"	Presupone capacidad en lugar de limitación
"Es que con su discapacidad..."	"En este contexto específico, necesita..."	Evita generalizar desde el diagnóstico

10.7 Comunicación con personas con dificultades expresivas

Algunas personas con discapacidad tienen dificultades para expresarse verbalmente de forma fluida: personas con disartria (dificultad motora en la producción del habla), personas con afasia (alteración del lenguaje por daño cerebral adquirido), personas con discapacidad intelectual que tienen un vocabulario expresivo más limitado que su comprensión real, o personas con TEA que pueden tener un estilo de comunicación verbal atípico.

En estos casos, las normas de comunicación que se aplican en interacciones ordinarias necesitan ser revisadas conscientemente.

Esperar sin completar. Cuando una persona tarda en encontrar la palabra o en terminar la frase, la tendencia automática es completar la frase por ella. Esto, aunque surge de la impaciencia más que de la mala intención, priva a la persona de la oportunidad de expresarse y transmite el mensaje de que su ritmo no es aceptable. Esperar, mantener el contacto visual y dar tiempo real es el acto comunicativo más respetuoso posible en estas situaciones.

No fingir comprensión. Si no se ha entendido lo que la persona ha expresado, decirlo con honestidad y pedir que lo repita o que lo exprese de otra forma. Fingir que se ha entendido para evitar la incomodidad del momento genera malentendidos mayores y priva a la persona de la posibilidad de hacerse entender realmente.

Explorar canales alternativos. Si la comunicación verbal es muy limitada, preguntar si la persona prefiere escribir, señalar, usar un sistema de comunicación aumentativa o alternativa, o responder mediante opciones de selección en lugar de producción libre.

Tabla 10.2 — Comunicación inclusiva por perfil

Perfil	Adaptación en instrucciones	Adaptación en preguntas	Adaptación en correcciones
Discapacidad intelectual	Pasos cortos, verbos concretos, soporte visual	Anticipadas, con opciones de elección	Privadas, con identificación de lo correcto primero
TEA	Literales, sin doble sentido, escritas además de orales	Con tiempo de procesamiento, anticipadas	Sin ironía, directas, en privado
TDAH	Una por una, con verificación activa, en soporte visual	Con tiempo, breves y concretas	Inmediatas, específicas, sin exposición pública
Discapacidad auditiva	Escritas, visibles, con contacto visual previo	Visibles para lectura labial o con intérprete	Por escrito o a través de intérprete
Discapacidad psicosocial	Predecibles, sin ambigüedad, con margen de tiempo	Sin presión de respuesta pública	Con mucha privacidad, separando error de persona
Dificultades expresivas	Sin cambios adicionales en la recepción	Tiempo real de espera, opciones de respuesta	Con canales alternativos de respuesta disponibles

CAPÍTULO 11: ADAPTACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

11.1 ¿Por qué adaptar no es rebajar?

La adaptación de actividades es el punto en que la teoría inclusiva se convierte en práctica concreta. Y es también el punto en que más resistencias aparecen, porque existe una creencia extendida entre los docentes de que adaptar una actividad significa bajar el nivel, reducir la exigencia o crear una versión de segunda categoría de lo que el resto del grupo hace.

Esta creencia es incorrecta, y vale la pena examinar por qué.

Una actividad formativa tiene siempre dos componentes que conviene separar con claridad: el objeto de aprendizaje, es decir, el conocimiento o la competencia que se quiere desarrollar, y el canal de acceso, es decir, el formato, el tiempo, los recursos y la modalidad a través de los cuales esa actividad se propone. Adaptar significa modificar el canal de acceso cuando este genera una barrera que impide a alguien demostrar lo que sabe. No significa modificar el objeto de aprendizaje.

Un alumno con discapacidad auditiva que no puede seguir un debate oral no tiene menos capacidad de argumentar que el resto del grupo. Tiene una barrera en el canal oral. Si el debate se complementa con una herramienta de comunicación escrita en tiempo real, el objeto de aprendizaje: argumentar, escuchar posiciones distintas, construir un razonamiento, permanece intacto. Solo el canal ha cambiado.

Esta distinción es la que permite mantener simultáneamente la exigencia académica y la accesibilidad. No son incompatibles. Son, bien entendidas, inseparables.

11.2 Debates

El debate es una de las actividades más frecuentes en contextos formativos y una de las más inaccesibles en su formato convencional para una parte significativa del alumnado con discapacidad.

El formato convencional del debate —intervenciones espontáneas, ritmo rápido, varios interlocutores simultáneos, ausencia de estructura predecible— genera barreras específicas para personas con discapacidad auditiva, con TEA, con ansiedad social, con discapacidad intelectual o con TDAH.

Adaptaciones para discapacidad auditiva: complementar el debate oral con una pizarra digital compartida en la que los participantes escriben sus argumentos principales en tiempo real. Designar un moderador que sintetice brevemente cada intervención antes de pasar a la siguiente. Utilizar subtítulos automáticos si está disponible.

Adaptaciones para TEA: comunicar con antelación el tema del debate y la estructura que seguirá. Asignar roles explícitos en lugar de dejar la participación abierta. Avisar a la persona con antelación del momento en que se le dará la palabra, para que pueda preparar su intervención sin la presión del tiempo real.

Adaptaciones para ansiedad social: ofrecer la posibilidad de preparar la intervención por escrito antes del debate. Permitir que la aportación se haga por escrito si la intervención oral genera una activación de ansiedad incompatible con la participación. Reducir el tamaño del grupo cuando sea posible.

Adaptaciones para discapacidad intelectual: proporcionar con antelación una ficha con dos o tres argumentos o frases de apoyo que la persona puede usar como punto de partida. Simplificar el tema sin reducir su relevancia. Dar tiempo adicional de procesamiento antes de pedir una respuesta.

Adaptaciones para TDAH: estructurar el debate con un sistema de turno explícito y visible, como una pelota que se pasa o un objeto físico que indica quién tiene la palabra. Hacer el debate más dinámico con cambios frecuentes de posición o de rol. Dividir el debate en bloques cortos con pausas entre ellos.

11.3 Exposiciones orales

La exposición oral es percibida por muchos docentes como una actividad de evaluación natural y universal. En realidad, es una actividad que mide simultáneamente el conocimiento del contenido, la capacidad de organización, la fluidez verbal, la regulación emocional bajo presión y la tolerancia a la exposición pública. Para muchas personas con discapacidad, la mayor parte de estas dimensiones son precisamente las más afectadas por su condición.

La pregunta relevante es: ¿qué se quiere evaluar con la exposición? Si el objetivo es evaluar el conocimiento del contenido, existen múltiples formas de hacerlo que no requieren exposición oral pública bajo presión. Si el objetivo es evaluar específicamente la competencia de comunicación oral, entonces hay que plantearse si la exposición convencional es la forma más justa de medir esa competencia en alumnado con discapacidades que afectan precisamente a esa competencia.

Adaptaciones posibles:

Permitir el uso de notas, guiones o apuntes durante la exposición. Esto no reduce la demostración de conocimiento: reduce la presión sobre la memoria de trabajo y permite que el conocimiento real sea visible.

Dar la opción de exponer ante un grupo reducido o solo ante el docente, en lugar de ante el grupo completo. El contenido es el mismo. La presión de la exposición pública, que para alguien con ansiedad social o con discapacidad psicosocial puede ser incapacitante, desaparece.

Permitir formatos alternativos que demuestren el mismo nivel de trabajo: un vídeo grabado con antelación, una presentación narrada en audio, un informe escrito con estructura de exposición, o una demostración práctica si el contenido lo permite.

Ampliar el tiempo disponible para la exposición, especialmente para personas con dificultades de fluidez verbal o de organización del discurso en tiempo real.

Testimonio simulado — Mariana, 22 años, TEA nivel 1:

En una formación de inserción sociolaboral, Mariana debía hacer una exposición de diez minutos sobre el proceso de búsqueda de empleo. El docente le comunicó el tema con una semana de antelación y le propuso que preparara un guión escrito que pudiera leer durante la exposición si en algún momento perdía el hilo. El día de la exposición, Mariana expuso con claridad y precisión técnica superior a la media del grupo. Lo que no habría podido hacer sin las adaptaciones era gestionar simultáneamente el contenido, la audiencia y la improvisación. Con el guión como soporte, solo tuvo que gestionar el contenido.

11.4 Trabajos en grupo

El trabajo en grupo es una de las actividades más valoradas pedagógicamente por su capacidad de desarrollar competencias sociales, de negociación y de aprendizaje colaborativo. Es también una de las que más dificultades genera para alumnado con discapacidad cuando no se gestiona con intención.

En un grupo sin estructura explícita, los roles tienden a distribuirse de forma informal según quien tiene mayor fluidez verbal, mayor iniciativa social y mayor capacidad de imponerse en la dinámica. Las personas con discapacidad intelectual, con TEA, con ansiedad social o con dificultades de comunicación oral quedan frecuentemente en posiciones marginales dentro del grupo: hacen las tareas más simples o las que nadie más quiere hacer, participan poco en las decisiones, y acaban siendo percibidas por el grupo como un elemento de poco valor. Esto no es un problema de las personas con discapacidad. Es un problema de diseño de la actividad.

Estrategias de adaptación estructural:

Asignar roles explícitos y escritos a cada miembro del grupo antes de que empiece la actividad. El rol debe describir con precisión qué hace esa persona, no de forma genérica. En lugar de «secretario», especificar «escribe en el documento compartido los acuerdos que tome el grupo durante la sesión de hoy».

Diseñar la tarea de forma que cada rol sea necesario para el resultado final. Si el rol de una persona puede no realizarse sin que el producto final cambie, esa persona no está realmente integrada en el grupo.

Hacer visibles las contribuciones de cada miembro. Si solo se evalúa el producto final grupal, las contribuciones individuales son invisibles y el sistema no da información sobre la participación real de cada persona.

Hacer seguimiento del proceso, no solo del resultado. El docente que solo ve el trabajo final no sabe cómo ha funcionado el grupo. Visitas breves al grupo durante el proceso de trabajo permiten identificar si alguien está siendo excluido y corregirlo en tiempo real.

11.5 Simulaciones y juegos de rol

Las simulaciones y los juegos de rol son herramientas pedagógicas especialmente potentes para la formación en inserción sociolaboral porque permiten practicar situaciones reales en un entorno con menor riesgo. Pero en su formato convencional pueden generar barreras significativas para personas con TEA, con ansiedad social o con discapacidad intelectual.

La imprevisibilidad inherente a un juego de rol abierto —no saber qué va a decir la otra persona, tener que improvisar respuestas en tiempo real, gestionar la interacción social espontánea mientras se mantiene el foco en el objetivo de la simulación— es exactamente lo que hace difícil la situación real para muchas personas con discapacidad, y reproducirla en el aula sin adaptaciones no la hace más manejable: la hace igual de difícil pero además añade la exposición ante el grupo.

Adaptaciones para hacer las simulaciones accesibles:

Proporcionar el guión de la simulación con antelación, incluyendo las posibles respuestas del interlocutor. Esto no elimina el valor de la práctica: elimina la sobrecarga de la improvisación y permite que la persona pueda concentrarse en los aspectos comunicativos que son el objeto real del aprendizaje.

Permitir ensayos previos con el docente o con un compañero de confianza antes de realizar la simulación ante el grupo.

Ofrecer tarjetas de apoyo con frases clave que la persona puede usar durante la simulación si en algún momento pierde el hilo.

Graduar la dificultad de la simulación: empezar con situaciones simples y predecibles antes de introducir complejidad e imprevisibilidad.

11.6 Pruebas objetivas

Las pruebas objetivas —tipo test, verdadero/falso, emparejamiento— son frecuentemente percibidas como el formato de evaluación más accesible porque no requieren producción escrita extensa. En realidad, tienen sus propias barreras para determinados perfiles.

Para personas con discapacidad visual, el formato de columnas paralelas para emparejar puede ser completamente inaccesible en formato papel si no hay suficiente contraste. Para personas con dificultades de procesamiento de la lectura, enunciados largos con múltiples condiciones encadenadas pueden evaluar la capacidad de procesamiento lector más que el conocimiento del contenido. Para personas con TDAH, el formato de prueba larga con

muchos ítems puede generar fatiga atencional progresiva que hace que los últimos ítems sean respondidos con menos precisión que los primeros, independientemente del nivel de conocimiento.

Adaptaciones:

Asegurar que los enunciados están redactados de forma clara, directa y sin ambigüedad. Esto mejora la accesibilidad para todos los perfiles sin reducir la validez de la prueba.

Ampliar el tiempo disponible. El tiempo ampliado es el ajuste razonable más documentado y más efectivo para una amplia variedad de condiciones: TDAH, discapacidad intelectual, DCA, fibromialgia, discapacidad visual.

Permitir el uso de materiales de apoyo como glosarios, formularios o esquemas de referencia cuando lo que se evalúa es la aplicación del conocimiento y no la memorización de términos.

Dividir la prueba en bloques con pausas entre ellos para personas con fatiga atencional o fatiga cognitiva.

Proporcionar la prueba en formato digital accesible para personas que usan lectores de pantalla o amplificadores.

11.7 Casos prácticos

Los casos prácticos son el formato de actividad más cercano a la realidad profesional y, bien diseñados, son inherentemente más accesibles que las pruebas de memorización porque permiten demostrar el conocimiento aplicado de múltiples formas.

La mayor barrera en los casos prácticos suele ser el volumen de texto del enunciado y la complejidad de la situación descrita. Para personas con dificultades de procesamiento lector o con limitaciones en la memoria de trabajo, un caso práctico de tres páginas con múltiples personajes, fechas y datos puede resultar cognitivamente inmanejable antes de que se llegue siquiera a la pregunta.

Adaptaciones:

Estructurar el caso en secciones claramente diferenciadas, con epígrafes que faciliten la localización de la información relevante.

Proporcionar un esquema o resumen de los datos principales del caso como material de apoyo durante la actividad.

Separar el caso práctico en partes que se entregan secuencialmente, de forma que la persona pueda procesar cada sección antes de recibir la siguiente.

Permitir la resolución del caso de forma oral en lugar de escrita cuando las dificultades de producción escrita son la barrera principal.

Tabla 11.1 — Adaptaciones de actividades formativas por perfil

Actividad	Discapacidad física	Discapacidad visual	Discapacidad auditiva	TEA	Discapacidad intelectual	TDAH	Discapacidad psicosocial
Debate	Acceso físico al espacio, tiempo real de respuesta	Debate sin soporte visual obligatorio	Pizarra digital compartida, subtitulación	Rol asignado, tema anticipado	Ficha de argumentos previa	Turno explícito, bloques cortos	Sin exposición forzada, grupo pequeño
Exposición oral	Sin barreras específicas	Sin soporte visual obligatorio para el público	Subtitulación, intérprete	Guión de apoyo, antelación, grupo reducido	Apoyos visuales, tiempo ampliado	Bloques cortos, soporte escrito	Grupo reducido o grabación previa
Trabajo en grupo	Acceso físico a materiales y espacio	Materiales en formato accesible	Rol escrito, comunicación escrita complementaria	Rol explícito, estructura predecible	Rol concreto y escrito, seguimiento del proceso	Rol activo con cambios frecuentes	Rol definido, sin exposición imprevista
Simulaciones	Sin barreras específicas	Sin soporte visual obligatorio	Guión previo, ensayo con intérprete	Guión anticipado, ensayo previo, tarjetas de apoyo	Ensayo previo, frases clave de apoyo	Guión estructurado, situaciones graduadas	Ensayo previo, situación predecible
Pruebas objetivas	Sin barreras específicas salvo motricidad fina	Formato digital accesible, letra grande	Sin barreras específicas	Sin ambigüedad, tiempo ampliado	Enunciados simplificados, tiempo ampliado	Prueba en bloques, tiempo ampliado	Sin exposición pública, tiempo ampliado
Casos prácticos	Sin barreras específicas	Formato digital accesible	Sin barreras específicas	Caso estructurado, información por secciones	Resumen de datos, entrega secuencial	Secciones cortas, esquema de datos	Entrega sin presión de tiempo, resolución oral posible

CAPÍTULO 12: EVALUACIÓN INCLUSIVA

12.1 ¿Qué evalúa realmente una evaluación?

La evaluación es el momento en que el sistema formativo le dice a una persona lo que cree que sabe, lo que cree que puede hacer y lo que cree que vale. Esta afirmación, formulada así de directamente, incomoda. Pero es una descripción precisa del impacto real que tiene la evaluación sobre la autoestima, la motivación y el proyecto de vida de las personas que pasan por procesos formativos, especialmente de aquellas que ya han acumulado experiencias previas de fracaso o de ser medidas con instrumentos que no estaban diseñados para su forma de funcionar.

El problema central de la evaluación convencional en relación con la discapacidad no es la exigencia. Es la confusión sistemática entre lo que se quiere medir y el canal a través del cual se mide. Un examen escrito a mano contra el tiempo no mide solo el conocimiento del contenido. Mide también la velocidad de escritura manual, la capacidad de recuperar información bajo presión temporal, la tolerancia a la ansiedad de rendimiento y la resistencia a la fatiga cognitiva en un período concentrado. Para alguien con DCA, con fibromialgia, con TDAH o con discapacidad motora, estas variables interferentes pueden determinar el resultado del examen de forma más significativa que el conocimiento real que se pretende evaluar.

La evaluación inclusiva no baja el listón. Afina la puntería: mide lo que dice que mide, sin que variables ajenas al objeto de evaluación contaminen el resultado.

12.2 Ajustes razonables en la evaluación

El concepto de ajuste razonable tiene base jurídica en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, y en el Real Decreto Legislativo 1/2013. Un ajuste razonable es una modificación o adaptación que no impone una carga desproporcionada y que es necesaria para garantizar que una persona con discapacidad pueda participar en igualdad de condiciones.

En el contexto de la evaluación, los ajustes razonables más documentados y más efectivos son los siguientes.

Ampliación del tiempo. Es el ajuste más universal y con mayor respaldo en la investigación. Beneficia de forma documentada a personas con TDAH, discapacidad intelectual, DCA, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, discapacidad visual y discapacidad motora. La ampliación habitual es de un 25 a un 50% del tiempo estándar, aunque en casos justificados puede ser mayor. Este ajuste no da ventaja a quien no lo necesita porque quien no tiene dificultades de procesamiento o de ejecución no usará el tiempo adicional de forma significativa.

Descansos durante la prueba. Para personas con fatiga cognitiva, con dolor crónico o con dificultades de regulación emocional, poder detener la prueba durante un período breve y retomar sin penalización puede ser la diferencia entre completarla y no completarla. El conocimiento no desaparece durante el descanso. La fatiga sí se reduce.

Formato alternativo de la prueba. Oral en lugar de escrito, o escrito en lugar de oral, en función de cuál es la barrera principal de la persona. Digital en lugar de papel para personas con discapacidad visual o motora. Con apoyos visuales para personas con discapacidad intelectual.

Espacio alternativo. Realizar la prueba en un espacio separado del grupo cuando el entorno colectivo genera niveles de ansiedad o de distracción que interfieren con el rendimiento. Esto es especialmente relevante para personas con TEA, con TDAH o con trastornos de ansiedad.

Uso de materiales de apoyo. Diccionarios, glosarios, calculadoras, esquemas de referencia, cuando el objeto de evaluación no es la memorización de esos elementos sino la capacidad de aplicarlos. Determinar qué materiales son admisibles requiere que el docente tenga claridad sobre qué está evaluando exactamente.

Lector o escribiente. Para personas con discapacidad visual severa o con discapacidad motora que impide la escritura, un lector o escribiente que actúe como intermediario sin añadir ni interpretar el contenido es un ajuste que garantiza que se evalúa el conocimiento y no la capacidad física de acceso al papel.

12.3 Evaluación por competencias

La evaluación por competencias es estructuralmente más inclusiva que la evaluación de contenidos aislados porque evalúa la capacidad de hacer algo con el conocimiento en un contexto real o simulado, en lugar de la capacidad de recuperar información descontextualizada bajo condiciones artificiales.

Una competencia como «identificar las necesidades de apoyo de una persona con discapacidad para elaborar un itinerario de inserción laboral» puede evaluarse de muchas formas: un caso práctico resuelto, una simulación de entrevista, un informe escrito, una exposición oral, un portfolio de evidencias. Ninguna de estas formas es inherentemente mejor que las otras. Son canales distintos para demostrar la misma competencia.

La evaluación por competencias, bien diseñada, permite al docente seleccionar el canal de demostración más accesible para cada persona sin modificar la competencia que se evalúa. Esta flexibilidad de canal es, en sí misma, el principio central de la evaluación inclusiva.

El portfolio de evidencias merece mención específica porque es especialmente adecuado para perfiles con variabilidad de rendimiento, como personas con trastorno bipolar, con síndrome de fatiga crónica o con condiciones que tienen períodos de mayor y menor funcionamiento. El portfolio recoge evidencias de aprendizaje a lo largo del tiempo, lo que permite que la evaluación refleje el nivel real de competencia sin que un día de bajo funcionamiento determine el resultado de todo el proceso.

12.4 Instrumentos alternativos de evaluación

La entrevista de evaluación es uno de los instrumentos más infrautilizados y más potentes para evaluar a personas con discapacidades que afectan a la producción escrita. Una conversación estructurada en la que el docente hace preguntas sobre el contenido y la persona responde de forma oral permite evaluar el nivel de comprensión y de análisis con mucha más precisión que un examen escrito cuando la escritura es la barrera principal.

La demostración práctica evalúa directamente la competencia en su contexto de aplicación. Para la formación en inserción sociolaboral, donde muchas competencias son de naturaleza procedimental y relacional, la demostración práctica —una simulación de entrevista de trabajo, la elaboración real de un CV adaptado, la conducción de una sesión de orientación— puede ser el instrumento de evaluación más válido independientemente de si hay discapacidad o no.

El examen oral individual permite al docente adaptar en tiempo real el nivel y la forma de las preguntas en función de las respuestas de la persona, algo imposible en un formato escrito. Permite también clarificar si una respuesta incompleta refleja falta de conocimiento o dificultad de expresión, lo que tiene implicaciones directas sobre la calificación.

El trabajo de aplicación a lo largo del período formativo, con entregas parciales y retroalimentación continua, distribuye la evaluación en el tiempo y reduce el peso desproporcionado de un único momento de evaluación final. Para personas con variabilidad de rendimiento o con dificultades de gestión del tiempo, este formato es significativamente más justo que la concentración de toda la evaluación en un examen final.

12.5 Retroalimentación como parte de la evaluación

La retroalimentación no es el final de la evaluación. Es su parte más importante desde el punto de vista del aprendizaje, y también la que con mayor frecuencia se hace de forma que genera daño en lugar de progreso.

Una retroalimentación efectiva e inclusiva reúne las siguientes características.

Es específica. «Debes mejorar» no es retroalimentación. «En el caso práctico identificaste correctamente el tipo de discapacidad pero no especificaste qué adaptaciones concretas requeriría el puesto de trabajo» es retroalimentación que la persona puede usar.

Es accionable. La retroalimentación debe indicar qué puede hacer la persona para mejorar, no solo en qué ha fallado. La orientación hacia adelante transforma el error en información útil.

Es oportuna. La retroalimentación que llega semanas después de la actividad ha perdido gran parte de su valor pedagógico. La retroalimentación en tiempo real o inmediatamente posterior al momento de aprendizaje es incomparablemente más eficaz.

Es privada cuando implica errores significativos. La retroalimentación correctiva sobre aspectos importantes del rendimiento no debe darse delante del grupo. Debe darse en un espacio que permita a la persona procesar sin la presión de la exposición pública.

Reconoce el progreso, no solo el nivel absoluto. Para una persona que parte de un punto de dificultad significativa, un progreso notable puede no llegar al nivel estándar del grupo. Una evaluación que solo mide el nivel absoluto no reconoce ese progreso y transmite el mensaje de que el esfuerzo no ha valido. Una evaluación que también mide el progreso individual reconoce el trabajo real y mantiene la motivación.

Caso práctico — Tomás, 38 años, DCA por ictus, formación en orientación laboral:

Tomás llegó al proceso formativo con una lentitud de procesamiento significativa resultado de su ictus. En el primer examen parcial, obtuvo una calificación baja a pesar de que, en la entrevista de evaluación posterior que el docente realizó con él, quedó claro que comprendía los conceptos con solidez. Lo que no podía hacer era recuperarlos y organizarlos bajo la presión del tiempo estándar. El docente propuso para el resto del proceso: tiempo ampliado en las pruebas escritas, posibilidad de examen oral complementario para clarificar respuestas incompletas, y evaluación parcial mediante casos prácticos resueltos en casa. En la evaluación final, Tomás obtuvo una calificación que reflejaba su conocimiento real. No el tiempo que tardaba en escribirlo.

12.6 Autoevaluación y evaluación entre pares

La autoevaluación y la evaluación entre pares son instrumentos que desarrollan la metacognición, es decir, la capacidad de pensar sobre el propio proceso de aprendizaje, y que pueden ser especialmente valiosos para personas con discapacidad cuando se implementan correctamente.

Para personas con discapacidad intelectual, la autoevaluación requiere instrumentos muy estructurados con criterios concretos y observables, no abstractos. Una rúbrica con descriptores del tipo «he explicado tres pasos del proceso» es más manejable que una escala de valoración subjetiva del tipo «he comprendido el tema».

Para personas con TEA o con ansiedad social, la evaluación entre pares puede ser una fuente de estrés significativo si no está muy bien estructurada. Definir con precisión el rol de quien evalúa, los criterios que debe usar y el formato en que debe dar la retroalimentación reduce la ambigüedad y hace la actividad manejable.

Para personas con TDAH, la autoevaluación regular a lo largo del proceso, en lugar de solo al final, funciona como un ancla atencional que ayuda a mantener la conciencia del propio progreso y de los pasos pendientes.

Tabla 1.1 — Ajustes razonables en evaluación por perfil

Perfil	Ajuste principal	Formato alternativo	Condiciones especiales
Discapacidad física con afectación motora	Escribiente o formato digital	Examen oral, demostración práctica	Mesa adaptada, tiempo ampliado
Discapacidad visual	Formato digital accesible, lector	Examen oral, portfolio	Sin elementos exclusivamente visuales
Discapacidad auditiva	Instrucciones escritas, sin componente exclusivamente oral	Informe escrito, portfolio	Intérprete si necesario
Discapacidad intelectual	Tiempo ampliado, enunciados simplificados	Demostración práctica, entrevista	Apoyo para comprensión de la instrucción
TEA	Espacio alternativo, tiempo ampliado	Portfolio, trabajo de aplicación	Sin cambios imprevistos en el formato
TDAH	Tiempo ampliado, prueba en bloques	Portfolio, demostración práctica	Espacio con mínimos distractores
Discapacidad psicosocial	Espacio alternativo, descansos	Portfolio, entrega progresiva	Flexibilidad ante episodios agudos
DCA	Tiempo ampliado, examen oral complementario	Portfolio, demostración práctica	Sin presión temporal extrema
Fibromialgia / SFC	Tiempo ampliado, descansos, horario flexible	Portfolio, entrega en casa	Posibilidad de aplazamiento justificado

CAPÍTULO 13: INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

13.1 ¿ Por qué la inserción laboral no es el punto final del proceso?

Existe una tendencia en los sistemas de orientación laboral a tratar la inserción como el objetivo terminal del proceso: la persona consigue un contrato y el trabajo del técnico ha concluido. Esta visión es incompleta y, en el caso de las personas con discapacidad, puede ser directamente contraproducente.

La inserción laboral es una transición, no un destino. Lo que ocurre antes de esa transición — la preparación, la exploración de capacidades, la identificación de barreras, el diseño del itinerario— y lo que ocurre después —el acompañamiento en el puesto, la gestión de los ajustes razonables, el mantenimiento del empleo— determina en mucha mayor medida el resultado real para la persona que el momento puntual de la firma del contrato.

Para las personas con discapacidad, las tasas de abandono en los primeros meses de empleo son significativamente más altas que para la población general, y las causas raramente tienen que ver con incompetencia técnica. Tienen que ver con barreras en el entorno laboral que no se anticiparon, con ajustes razonables que no se solicitaron o no se implementaron, con dinámicas relacionales en el equipo que nadie preparó, y con una sobrecarga de adaptación que la persona fue absorbiendo sola hasta que ya no pudo.

El técnico de inserción sociolaboral que entiende esto diseña el proceso de forma que incluya todas estas dimensiones, no solo las que ocurren antes de la contratación.

13.2 El itinerario personalizado de inserción

El itinerario personalizado de inserción es la herramienta central del trabajo del técnico de inserción sociolaboral. No es un formulario ni un protocolo estándar. Es un proceso de construcción conjunta con la persona que parte de tres preguntas fundamentales: dónde está ahora, adónde quiere ir y qué necesita para recorrer la distancia entre los dos puntos.

La primera pregunta exige una evaluación que no se limite a los déficits. Los itinerarios basados exclusivamente en lo que la persona no puede hacer producen itinerarios que llevan a empleos que nadie elegiría si pudiera elegir. Una evaluación de capacidades real incluye: habilidades técnicas, habilidades sociales y comunicativas, experiencias previas formales e informales, intereses y motivaciones, red de apoyo disponible, nivel de autonomía en distintos contextos, y tolerancia a distintos tipos de entorno laboral.

La segunda pregunta exige que el técnico escuche antes de proponer. Con demasiada frecuencia los itinerarios de inserción de personas con discapacidad están diseñados desde las expectativas del sistema y no desde las aspiraciones de la persona. El resultado es una persona

que llega a un puesto de trabajo que no ha elegido, con una motivación intrínseca baja y una probabilidad de mantenimiento reducida.

La tercera pregunta es donde el trabajo técnico cobra todo su sentido: identificar con precisión qué barreras existen entre la situación actual y el objetivo, y diseñar estrategias concretas para cada una de ellas.

Caso práctico — Alejandro, 33 años, discapacidad intelectual moderada:

"En todos los sitios que fui me preguntaban qué sabía hacer. Nadie me preguntó qué quería hacer. Un día la orientadora me preguntó en qué sitios me había sentido bien. Le dije que en la panadería de mi barrio, que a veces ayudaba. Me preguntó qué era lo que me gustaba de estar ahí. Le dije que el olor, el orden de las cosas, que siempre sabía lo que tocaba hacer. Empezamos desde ahí. Ese itinerario sí funcionó."

13.3 Modalidades de inserción

El marco español de inserción sociolaboral de personas con discapacidad contempla un continuo de modalidades que van desde el empleo más protegido hasta el empleo ordinario en mercado abierto. Conocer este continuo y saber cuándo cada modalidad es la más adecuada es una competencia técnica central del orientador laboral.

Centros Ocupacionales. No son modalidades de empleo sino espacios de terapia ocupacional y de preparación para el empleo. La persona realiza actividades productivas o prelaborales sin relación contractual laboral. Pueden percibir una gratificación económica de hasta el 30% del Salario Mínimo Interprofesional. Su función es el desarrollo de habilidades prelaborales, la estructuración del tiempo y la preparación para etapas posteriores del itinerario. Son especialmente adecuados para personas que aún no tienen el nivel de autonomía o de habilidades básicas necesario para el entorno laboral, pero no deben convertirse en un destino permanente cuando la persona tiene capacidad de avanzar.

Centros Especiales de Empleo (CEE). Son empresas cuya plantilla debe estar compuesta en un mínimo del 70% por personas con discapacidad. Ofrecen empleo real con contrato laboral, salario y cotización a la Seguridad Social. Están diseñados para personas que necesitan un entorno laboral más protegido y con apoyos específicos, pero que tienen capacidad de trabajo productivo. Disponen de Servicios de Ajuste Personal y Social y de Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional que prestan acompañamiento individualizado. La limitación que se les señala con frecuencia desde la perspectiva de la inclusión es que pueden convertirse en entornos cerrados que dificultan la transición al mercado ordinario cuando esa transición sería posible y deseable para la persona.

Enclave laboral. Es la figura que articula la transición entre el CEE y el mercado ordinario. Un grupo de trabajadores del CEE se desplaza a trabajar dentro de una empresa ordinaria, realizando tareas para esa empresa bajo la supervisión del CEE. Permite a la persona experimentar el entorno del mercado ordinario manteniendo el apoyo del CEE, y permite a la empresa conocer las capacidades reales de trabajadores con discapacidad antes de una eventual contratación directa.

Empleo con Apoyo (ECA). Es el modelo que mayor evidencia acumulada tiene en la literatura internacional sobre inserción laboral de personas con discapacidad. Consiste en la inserción directa en empresas del mercado ordinario con el acompañamiento de un preparador laboral especializado que apoya tanto a la persona como a la empresa durante el proceso de incorporación y hasta que el empleo se estabiliza. La filosofía del ECA es «primero coloca, luego forma», en contraposición a los modelos tradicionales de «primero forma, luego coloca». La evidencia muestra que las personas inseridas mediante ECA tienen tasas de mantenimiento del empleo significativamente superiores a las inseridas sin este apoyo.

Empleo ordinario sin apoyo especializado. Es la modalidad más normalizada y la que mayor integración real produce, pero también la que mayores exigencias de autonomía y de capacidad de adaptación requiere. Para que sea sostenible, suele requerir que se hayan trabajado previamente las habilidades de autodefensa (capacidad de identificar y comunicar las propias necesidades en el entorno laboral) y que la persona tenga claridad sobre los ajustes razonables a los que tiene derecho y cómo solicitarlos.

13.4 El preparador laboral

El preparador laboral es la figura profesional central del Empleo con Apoyo. Su función no es hacer el trabajo por la persona ni actuar como supervisor. Es facilitar la adaptación mutua entre la persona y el entorno laboral, identificar y resolver las barreras que van apareciendo, y reducir gradualmente el nivel de apoyo a medida que la persona y la empresa alcanzan un funcionamiento autónomo.

Las funciones del preparador laboral se despliegan en tres momentos del proceso.

Antes de la incorporación: análisis del puesto de trabajo para identificar las exigencias reales del mismo y anticipar qué ajustes pueden ser necesarios; preparación de la persona para las especificidades del puesto; sensibilización del equipo de trabajo y de la persona responsable de RRHH; y negociación de los ajustes razonables con la empresa.

Durante la incorporación: presencia en el puesto de trabajo en los primeros días o semanas, con una intensidad de apoyo que va disminuyendo progresivamente; modelado de las tareas cuando es necesario; mediación en las situaciones relacionales que generan dificultad; apoyo a la empresa para resolver dudas sobre cómo comunicarse o trabajar con la persona; y monitorización de señales de dificultad en ambas partes.

Después de la estabilización: seguimiento a distancia para detectar problemas antes de que se conviertan en crisis; disponibilidad para reactivar el apoyo presencial si la situación lo requiere; acompañamiento ante cambios en el puesto, cambios de supervisor o cambios en las condiciones de trabajo.

Un error frecuente en la implementación del ECA es retirar el apoyo demasiado pronto, en el momento en que la situación parece estable, sin haber consolidado suficientemente la autonomía de la persona y la capacidad de la empresa para gestionar situaciones imprevistas sin apoyo externo.

13.5 Análisis del puesto de trabajo para la inserción

El análisis del puesto de trabajo (APT) orientado a la inserción de personas con discapacidad no es un análisis de recursos humanos convencional. Su objetivo no es describir el puesto para seleccionar al candidato más estándar, sino identificar con precisión cuáles son las exigencias reales del puesto, cuáles de esas exigencias son esenciales y cuáles son accesorias, y qué modificaciones o adaptaciones permitirían que una persona con una determinada condición pudiera realizarlo con plena competencia.

Esta distinción entre exigencias esenciales y accesorias es fundamental. Una exigencia es esencial cuando su eliminación cambiaría la naturaleza del trabajo. Es accesorio cuando su modificación no afecta al resultado productivo pero sí puede eliminar una barrera para una persona con discapacidad.

Por ejemplo, en un puesto de atención al cliente en mostrador, la comunicación efectiva con el cliente es una exigencia esencial. El canal a través del cual esa comunicación se produce — verbal oral, escrito, por gestos, con apoyo de tecnología— es en muchos casos una exigencia accesorio que puede modificarse sin alterar la calidad del servicio.

El APT orientado a la inserción incluye: observación directa del puesto en condiciones reales de trabajo; entrevista con el trabajador que actualmente ocupa ese puesto o uno equivalente; análisis de las condiciones físicas, sensoriales y cognitivas que el puesto requiere; identificación de las interacciones sociales y comunicativas que forman parte del trabajo; análisis del entorno físico para detectar barreras de accesibilidad; y propuesta de ajustes razonables específicos para el perfil de la persona que se va a inserir.

13.6 Ajustes razonables en el entorno laboral

El ajuste razonable en el entorno laboral es una obligación legal establecida por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la normativa española de igualdad de trato. Las empresas están obligadas a realizar los ajustes razonables necesarios para que una persona con discapacidad pueda acceder al empleo, desarrollarlo y progresar en él, salvo que estos ajustes impongan una carga desproporcionada para la empresa.

La determinación de qué es «desproporcionado» no es subjetiva: depende del tamaño de la empresa, de los recursos disponibles, de las ayudas públicas existentes para financiar el ajuste y del impacto real del ajuste sobre la organización. En la práctica, la mayoría de los ajustes razonables tienen un coste bajo o nulo y un impacto significativo sobre la capacidad de la persona de desarrollar su trabajo.

Los ajustes razonables más frecuentes en el entorno laboral se agrupan en varias categorías.

Adaptaciones físicas del puesto: modificación de la altura de la mesa o de los elementos de trabajo para personas que utilizan silla de ruedas; instalación de rampas o eliminación de barreras arquitectónicas en el espacio de trabajo; iluminación específica para personas con baja visión; reducción del nivel de ruido o creación de espacios de trabajo con menor estimulación sensorial para personas con hipersensibilidad.

Adaptaciones tecnológicas: software de lectura de pantalla o amplificación para personas con discapacidad visual; sistemas de subtítulos para reuniones o formaciones internas para personas con discapacidad auditiva; software de dictado por voz para personas con discapacidad motora que afecta a las manos; aplicaciones de organización y recordatorio para personas con TDAH o con DCA.

Adaptaciones organizativas: modificación del horario de entrada o salida para personas con condiciones que afectan al funcionamiento en determinadas horas del día; descansos adicionales para personas con fatiga crónica o dolor; flexibilidad en la gestión de las ausencias para personas con condiciones de salud variables; teletrabajo parcial cuando las tareas lo permiten y el entorno doméstico es más accesible o menos estimulante.

Adaptaciones en la comunicación: instrucciones escritas además de orales; reuniones con orden del día anticipado para personas con TEA o con ansiedad; acceso a un interlocutor de referencia claro para personas con dificultades de procesamiento social.

Adaptaciones en la carga de trabajo: distribución diferente de las tareas dentro del equipo para que las que requieren las habilidades más afectadas por la discapacidad no recaigan de forma desproporcionada sobre la persona; mayor tiempo para la realización de ciertas tareas cuando la lentitud de procesamiento o la fatiga lo justifican.

13.7 La sensibilización de las empresas

La sensibilización empresarial es una dimensión del trabajo del técnico de inserción que con frecuencia se aborda de forma superficial: una charla informativa, un folleto, datos estadísticos sobre productividad de los trabajadores con discapacidad. Estas acciones tienen un impacto limitado porque no modifican las actitudes ni las prácticas concretas de las personas que van a trabajar día a día con el trabajador insertado.

La sensibilización eficaz no informa sobre la discapacidad en abstracto. Trabaja con el equipo concreto, en el puesto concreto, sobre las situaciones específicas que van a ocurrir. Responde a las preguntas reales que los compañeros tienen pero no se atreven a hacer: ¿cómo le digo si hace algo mal?, ¿qué hago si no entiendo lo que me dice?, ¿puedo pedirle que haga algo distinto a lo que está haciendo?, ¿hay algo que no deba hacer o decir?

La figura del trabajador de apoyo natural, es decir, un compañero del equipo que actúa como referente informal para la persona insertada, es uno de los recursos más eficaces y menos costosos para facilitar la integración en el equipo. No requiere formación especializada: requiere disposición y un briefing claro sobre cuál es su papel.

Caso práctico — Sandra, 27 años, TEA nivel 1, insertada en un puesto administrativo:

El preparador laboral realizó una sesión de treinta minutos con el equipo de cinco personas antes de que Sandra se incorporara. No habló de autismo en general. Habló de Sandra: que prefería las instrucciones escritas, que no le gustaban los cambios de último momento sin aviso, que podía parecerles poco sociable pero que eso no significaba que no quisiera estar en el equipo, y que si tenían cualquier duda era mejor preguntarle directamente a ella que intentar deducirlo. Tres meses después, Sandra seguía en el puesto. La empresa describió su rendimiento como excelente en las tareas. Un compañero describió la situación así: "Al principio no sabíamos cómo tratarla. Después de la charla, simplemente la tratamos."

13.8 Mantenimiento del empleo

El mantenimiento del empleo es la dimensión más descuidada de los sistemas de inserción laboral y la que mayor impacto tiene sobre los resultados a largo plazo. Una persona que pierde el empleo a los tres meses de haberlo conseguido no solo ha perdido ese empleo: ha acumulado una nueva experiencia de fracaso que reduce su disposición a intentarlo de nuevo y que el sistema raramente tiene en cuenta en el siguiente itinerario.

Las causas más frecuentes de pérdida de empleo en personas con discapacidad no son el rendimiento técnico deficiente. Son: dificultades en las relaciones con compañeros o supervisores que no se gestionaron a tiempo; cambios en el puesto, el equipo o las condiciones de trabajo que generaron una barrera nueva que nadie resolvió; deterioro de la salud que no se anticipó en el diseño del puesto; agotamiento por la ausencia de ajustes razonables que la persona no supo cómo solicitar; y conflictos que escalaron hasta el despido porque no había un canal de mediación disponible.

El seguimiento activo del empleo, con contacto regular tanto con la persona como con la empresa, permite detectar estas situaciones en una fase temprana en que son resolubles, antes de que lleguen a un punto de no retorno.

Tabla 13.1 — Modalidades de inserción sociolaboral: características y criterios de adecuación

Modalidad	Perfil más adecuado	Nivel de apoyo	Transición posible
Centro Ocupacional	Personas con alta necesidad de apoyo, en fase prelaboral	Máximo, continuo	Hacia CEE o ECA con proceso de preparación
CEE	Personas con necesidad de entorno protegido con empleo real	Alto, integrado en la empresa	Hacia enclave o mercado ordinario si la persona lo desea
Enclave laboral	Personas en transición desde CEE hacia mercado ordinario	Medio, con respaldo del CEE	Hacia contratación directa por empresa ordinaria
Empleo con Apoyo	Personas con capacidad para mercado ordinario con apoyo inicial	Variable, decreciente	Hacia empleo ordinario autónomo
Empleo ordinario	Personas con autonomía suficiente y habilidades de autodefensa	Bajo o nulo	Mantenimiento con seguimiento puntual

Tabla 13.2 — Ajustes razonables en el entorno laboral por tipo de discapacidad

Tipo de discapacidad	Ajustes físicos	Ajustes tecnológicos	Ajustes organizativos	Ajustes comunicativos
Física motora	Mesa adaptada, rampa, ascensor, aparcamiento	Software de dictado, periféricos adaptados	Horario flexible, teletrabajo, descansos	Sin cambios específicos
Visual	Iluminación específica, ausencia de reflejos	Lector de pantalla, amplificador, braille	Sin cambios específicos	Información siempre en formato accesible
Auditiva	Bucle magnético, señales visuales de alarma	Subtitulación de reuniones, videollamada con intérprete	Reuniones con orden del día previo	Instrucciones escritas, interlocutor visible
Intelectual	Sin cambios específicos generales	Aplicaciones de organización, pictogramas	Tareas descompuestas, rutinas claras, supervisor de referencia	Instrucciones simples, verificación de comprensión
TEA	Espacio de trabajo con estimulación reducida	Sin cambios específicos	Horario predecible, aviso de cambios, rol claro	Comunicación explícita y directa, instrucciones escritas
TDAH	Espacio con pocos distractores	Aplicaciones de organización y recordatorio	Tareas con plazos intermedios, variedad de actividades	Instrucciones escritas, retroalimentación frecuente
Psicosocial	Espacio tranquilo disponible	Sin cambios específicos	Flexibilidad en gestión de ausencias, carga ajustable	Comunicación predecible, interlocutor de referencia
DCA	Según afectación específica	Según afectación específica	Más tiempo para tareas, descansos, ritmo progresivo	Instrucciones escritas, verificación de comprensión

CAPÍTULO 14: QUÉ NO DEBE HACER UN PROFESIONAL

14.1 Por qué un capítulo de errores

Los errores que cometen los profesionales que trabajan con personas con discapacidad raramente nacen de la mala voluntad. Nacen de la falta de información, de los prejuicios interiorizados sin haberlos examinado, de la incomodidad ante situaciones que el sistema de formación profesional no preparó para gestionar, y de una tendencia humana a reproducir lo que se ha visto hacer a otros, incluso cuando lo que se vio hacer causaba daño.

Identificar estos errores con precisión, nombrar sus consecuencias reales y ofrecer alternativas concretas es un acto de respeto hacia las personas con discapacidad y hacia los propios profesionales, que merecen saber con exactitud qué prácticas deben revisar y por qué.

Los veinte errores que se describen a continuación están ordenados por ámbito de impacto, no por frecuencia ni por gravedad. Todos ocurren. Todos tienen consecuencias. Todos tienen alternativa.

ERROR 1 — Hablar sobre la persona en su presencia como si no estuviera

Qué ocurre: El docente u orientador se dirige al acompañante, al familiar o al intérprete para preguntar sobre la persona con discapacidad mientras esta está presente. «¿Puede seguir el ritmo del grupo?», «¿entiende bien las instrucciones?», «¿qué necesita exactamente?»

Consecuencia real: La persona experimenta una exclusión simbólica que comunica con precisión que su voz no cuenta, que otros son más fiables para hablar de su propia experiencia, y que el profesional no la ve como interlocutora válida. Este mensaje, repetido en distintos contextos a lo largo de la vida, tiene un impacto acumulativo sobre la autoestima y la disposición a comunicar las propias necesidades.

Alternativa: Dirigirse siempre en primer lugar a la persona, directamente y mirándola. Si hay acompañante o intérprete, es la persona con discapacidad quien decide si y cuándo quiere que ese acompañante intervenga. El profesional no toma esa decisión por ella.

ERROR 2 — Asumir las capacidades y limitaciones sin preguntar

Qué ocurre: El docente decide, basándose en el diagnóstico o en la apariencia, qué puede y qué no puede hacer la persona. Exime de determinadas actividades, reduce la exigencia o asigna tareas más simples sin haber hablado con la persona sobre sus capacidades reales.

Consecuencia real: Dos consecuencias simultáneas y opuestas. En unos casos, la persona se encuentra excluida de actividades que podría realizar con los apoyos adecuados. En otros, se la incluye en actividades para las que genuinamente necesita adaptaciones que no se le ofrecen porque el docente asumió que podía sin ayuda. En ambos casos, el punto de partida equivocado es el mismo: la suposición sin pregunta.

Alternativa: Establecer una conversación privada al inicio del proceso formativo. Preguntar directamente qué aspectos del entorno o de las actividades generan dificultad, qué adaptaciones han funcionado en experiencias anteriores, y qué prefiere la persona en cuanto a cómo se gestiona la información sobre sus necesidades dentro del grupo.

ERROR 3 — Infantilizar

Qué ocurre: El docente utiliza con personas adultas con discapacidad un tono de voz, un vocabulario o una actitud que sería adecuada con niños pequeños. Habla más lento de lo necesario, usa diminutivos, simplifica el lenguaje hasta el punto de vaciarlo de contenido técnico, o celebra logros ordinarios con una efusividad que nadie usaría con el resto del grupo.

Consecuencia real: La infantilización comunica que el profesional no considera a la persona como un adulto capaz. Deteriora la dignidad, reduce la motivación y genera una relación pedagógica basada en la asimetría de poder en lugar de en el respeto mutuo. Las personas adultas con discapacidad intelectual son especialmente vulnerables a este error, que es también el más difícil de reconocer porque quien lo comete suele creer que está siendo amable.

Alternativa: Usar con todas las personas el mismo registro comunicativo base, ajustando solo lo que sea estrictamente necesario para la comprensión. El ajuste debe hacerse en la estructura de las frases y en el vocabulario técnico cuando sea preciso, no en el tono ni en la actitud. La amabilidad no requiere condescendencia.

ERROR 4 — Reducir la exigencia sin consensuarlo

Qué ocurre: El docente decide unilateralmente que la persona con discapacidad no necesita cumplir los mismos requisitos que el resto del grupo. La exime de partes de la evaluación, reduce los contenidos sin informarla o acuerda con la institución una calificación «especial» que no refleja el proceso real.

Consecuencia real: La persona obtiene una certificación o calificación que no corresponde a lo que ha aprendido, lo que la sitúa en una posición de vulnerabilidad cuando esa certificación se confronte con la realidad del mercado laboral. Además, recibe el mensaje implícito de que el sistema no confía en su capacidad de alcanzar los objetivos reales, lo que tiene un impacto directo sobre su autoestima y sus propias expectativas.

Alternativa: Separar con claridad los ajustes razonables, que modifican el canal de acceso manteniendo el nivel de exigencia, de las adaptaciones curriculares significativas, que modifican los objetivos y que requieren un proceso formal, documentado y consensuado con

la persona y, cuando corresponda, con el equipo de apoyo. En ningún caso se reducen las expectativas sin que la persona lo sepa y lo consienta.

ERROR 5 — Exponer públicamente las necesidades de la persona sin su consentimiento

Qué ocurre: El docente informa al grupo sobre la discapacidad de un alumno, explica sus adaptaciones delante de todos, o hace comentarios sobre sus necesidades en sesiones plenarias sin haber preguntado a la persona si quiere que esa información se comparta.

Consecuencia real: La persona pierde el control sobre información sensible sobre sí misma. Puede experimentar vergüenza, rechazo social o un cambio en la dinámica relacional con el grupo que dificulta su participación. En algunos casos, la exposición pública de información sobre condiciones de salud mental puede reactivar el estigma precisamente en el entorno en que la persona necesita sentirse segura.

Alternativa: Preguntar siempre a la persona qué información, si alguna, quiere que se comparta con el grupo y en qué términos. Gestionar las adaptaciones de la forma más discreta posible. Cuando las adaptaciones sean visibles para el grupo, normalizarlas sin señalar a la persona: «en este grupo podemos pedir más tiempo si lo necesitamos» en lugar de «Jorge necesita más tiempo por su condición».

ERROR 6 — Interpretar la fatiga como falta de interés o de esfuerzo

Qué ocurre: El docente observa que la persona rinde de forma variable, que en algunos momentos de la sesión o en algunos días desconecta, comete más errores o tarda más en responder, e interpreta esto como desmotivación, pereza o falta de compromiso.

Consecuencia real: La persona recibe retroalimentación negativa sobre una conducta que no controla, lo que genera frustración, vergüenza y una progresiva reducción de la disposición a participar. En condiciones como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el TDAH, la esclerosis múltiple o el DCA, la fatiga es un síntoma real con base fisiológica documentada, no una actitud que pueda modificarse con mayor motivación.

Alternativa: Incorporar pausas regulares como norma de aula para todos. Cuando se observa variabilidad de rendimiento en una persona, preguntar en privado cómo se encuentra y si hay algo que pueda facilitar su participación. Diseñar las sesiones con bloques de actividad variada que permitan la recuperación atencional sin que nadie tenga que pedirlo explícitamente.

ERROR 7 — Completar las frases o pensamientos de la persona

Qué ocurre: Cuando una persona con dificultades de fluidez verbal, con afasia, con discapacidad intelectual o con TEA tarda en encontrar la palabra o en terminar una idea, el

docente completa la frase por ella, a menudo incorrectamente o con una interpretación que no coincide con lo que la persona quería expresar.

Consecuencia real: La persona aprende que su ritmo no es aceptable en ese entorno y que si espera demasiado, otro hablará por ella. Esto reduce progresivamente los intentos de comunicación autónoma. Además, cuando la interpretación del docente es incorrecta y no se corrige, se genera un malentendido que puede afectar a decisiones sobre el itinerario o sobre las adaptaciones.

Alternativa: Esperar. Mantener el contacto visual. No llenar el silencio. Si la persona parece bloqueada, ofrecer opciones de elección en lugar de completar: «¿estabas pensando en algo relacionado con el proceso de selección o con otra parte del tema?». Y si se ha interpretado incorrectamente, crear el espacio para que la persona lo corrija sin que eso suponga un coste relacional.

ERROR 8 — Usar lenguaje que cosifica o estigmatiza

Qué ocurre: El docente o técnico usa expresiones como «el discapacitado», «la sorda», «los autistas», «sufre de depresión», «es un esquizofrénico», «los que tienen problemas», o habla de la discapacidad en términos de tragedia, limitación o carencia de forma sistemática.

Consecuencia real: El lenguaje modela la percepción. Cuando el docente usa un lenguaje que cosifica o que enmarca la discapacidad como tragedia, transmite ese marco al grupo. Las personas con discapacidad presentes en el aula internalizan ese marco sobre sí mismas. Las personas sin discapacidad construyen sus actitudes sobre ese marco. El resultado es un entorno menos seguro para todos.

Alternativa: Lenguaje centrado en la persona de forma sistemática y natural, sin que se convierta en una performance de corrección política. «Persona con discapacidad auditiva» en lugar de «la sorda». «Tiene esquizofrenia» en lugar de «es un esquizofrénico». «Presenta dificultades en este contexto específico» en lugar de «tiene problemas». El cambio de lenguaje no es cosmético. Refleja y genera un cambio real en la forma de ver a la persona.

ERROR 9 — No anticipar las barreras del entorno

Qué ocurre: El docente o técnico llega al espacio formativo sin haber verificado su accesibilidad. Descubre el día de la sesión que hay escaleras sin rampa, que el proyector no tiene suficiente contraste, que la sala tiene una acústica que hace imposible la lectura labial, o que los materiales solo están disponibles en un formato inaccesible para algún participante.

Consecuencia real: La persona con discapacidad se encuentra con una barrera el día en que se supone que debe aprender. La barrera no se resuelve ese día. La persona pierde acceso a parte o a toda la sesión. Y recibe el mensaje de que su presencia no fue suficientemente anticipada como para que alguien comprobara de antemano si el entorno era accesible para ella.

Alternativa: La verificación de la accesibilidad del entorno es parte de la preparación de cualquier sesión formativa, no una tarea extraordinaria. Incluye el espacio físico, los materiales, la tecnología disponible y las vías de comunicación. Cuando hay participantes con necesidades de accesibilidad conocidas, la verificación se hace en función de esas necesidades específicas con antelación suficiente para resolver lo que no esté en condiciones.

ERROR 10 — Gestionar los conflictos de la persona con discapacidad de forma diferente sin justificación

Qué ocurre: Cuando surge un conflicto que implica a una persona con discapacidad, el docente lo gestiona de forma distinta a como gestionaría el mismo conflicto con otra persona: evita el confrontamiento directo por incomodidad, tolera conductas que no toleraría en otros, o por el contrario reacciona de forma más severa ante una conducta que en realidad es una señal de una necesidad no cubierta.

Consecuencia real: En el primer caso, la persona no recibe el feedback que necesita para regular su conducta y que tiene derecho a recibir como cualquier otro participante. En el segundo, se sanciona una conducta cuya causa real no se ha entendido, lo que no resuelve el problema y daña la relación.

Alternativa: Gestionar los conflictos con las mismas normas de equidad y de privacidad que se usarían con cualquier otra persona, añadiendo la dimensión de comprensión de la causa. Antes de responder a una conducta problemática, preguntarse si esa conducta puede ser la expresión visible de una necesidad no cubierta o de una barrera no resuelta.

ERROR 11 — Sobreproteger bajo la apariencia de cuidado

Qué ocurre: El docente o técnico toma decisiones en nombre de la persona «para evitarle dificultades»: la exime de actividades que podrían ser complicadas, resuelve los problemas antes de que la persona los intente, gestiona situaciones que la persona podría gestionar sola con los apoyos adecuados.

Consecuencia real: La indefensión aprendida que genera la sobreprotección sistemática es uno de los obstáculos más documentados para la inserción laboral de personas con discapacidad. Una persona que ha aprendido que otros resuelven sus problemas no ha desarrollado las habilidades de autogestión y autodefensa que necesita para mantenerse en un puesto de trabajo de forma autónoma.

Alternativa: Ofrecer el apoyo necesario para que la persona pueda intentarlo, no para que no tenga que intentarlo. La diferencia entre apoyo y sobreprotección es que el apoyo tiene como objetivo volverse innecesario. La sobreprotección tiene como efecto volverse imprescindible.

ERROR 12 — No documentar los acuerdos ni los ajustes establecidos

Qué ocurre: El docente acuerda verbalmente con la persona determinadas adaptaciones o ajustes pero no los registra. Cuando hay un cambio de docente, cuando la persona pasa a otra fase del proceso o cuando surge una discrepancia sobre lo que se acordó, no hay constancia de nada.

Consecuencia real: La persona tiene que renegociar sus adaptaciones cada vez que cambia de interlocutor, lo que supone un coste emocional y de tiempo significativo. En los casos en

que las adaptaciones no se reconocen porque no están documentadas, la persona puede verse privada de ajustes razonables a los que tiene derecho.

Alternativa: Registrar por escrito los acuerdos de adaptación desde el inicio del proceso, con el conocimiento y el consentimiento de la persona. Este registro forma parte del expediente formativo y debe acompañar a la persona a lo largo de todo el itinerario.

ERROR 13 — Confundir conducta con diagnóstico

Qué ocurre: El docente observa una conducta —una respuesta impulsiva, una negativa a participar, un episodio de desconexión, una reacción emocional intensa— y la atribuye directamente al diagnóstico de la persona sin considerar otros factores contextuales.

Consecuencia real: Se pierde información crucial sobre lo que está ocurriendo realmente. Una persona con TDAH que ese día está especialmente dispersa puede estarlo porque no ha dormido, porque está en un período de mayor estrés, porque la sesión lleva dos horas sin pausas o porque el contenido de la sesión está generando ansiedad. Atribuir la dispersión al TDAH como categoría genérica no resuelve ninguno de estos problemas.

Alternativa: Observar la conducta en contexto. Preguntarse qué ha pasado antes, qué está pasando en el entorno, qué necesidad puede estar expresando esa conducta. Y cuando sea posible, preguntarle directamente a la persona qué está ocurriendo.

ERROR 14 — Asumir que los ajustes razonables son favores

Qué ocurre: El docente o la institución trata las adaptaciones y los ajustes razonables como concesiones excepcionales que se otorgan de forma discrecional, en lugar de como derechos garantizados por la normativa vigente. Esto puede manifestarse en el tono con que se comunica el ajuste, en las condiciones que se ponen para otorgarlo o en la actitud de quien lo gestiona.

Consecuencia real: La persona que necesita un ajuste razonable para participar en igualdad de condiciones aprende que pedir ese ajuste implica una negociación, una justificación repetida y una deuda de gratitud. Esto reduce significativamente la probabilidad de que pida los apoyos que necesita, especialmente en contextos nuevos.

Alternativa: Tratar los ajustes razonables como lo que son: obligaciones legales y condiciones de acceso a las que toda persona con discapacidad tiene derecho. Implementarlos con la misma naturalidad con que se adapta una silla a la altura de una mesa o se ajusta el volumen de un micrófono.

ERROR 15 — No actualizar los conocimientos sobre discapacidad

Qué ocurre: El docente o técnico trabaja con personas con discapacidad basándose en conocimientos adquiridos hace años, sin actualización. Usa terminología obsoleta, aplica modelos explicativos superados por la evidencia, o desconoce condiciones que han ganado

reconocimiento y visibilidad en los últimos años como el síndrome de fatiga crónica, la hipersensibilidad sensorial en adultos o el TDAH en mujeres.

Consecuencia real: La práctica profesional basada en conocimiento desactualizado puede causar daño real: una persona con síndrome de fatiga crónica a quien se anima a «esforzarse más» puede sufrir un empeoramiento de sus síntomas documentado como malestar post-esfuerzo. Un adulto con TDAH no diagnosticado al que se le dice que «tiene que organizarse mejor» no recibe la orientación que necesita.

Alternativa: La formación continua en el ámbito de la discapacidad no es un complemento opcional de la práctica profesional. Es una responsabilidad ética. Incluye la actualización en evidencia científica, en normativa, en tecnologías de apoyo y, especialmente, en las narrativas de las propias personas con discapacidad sobre su experiencia.

ERROR 16 — Interpretar el silencio como comprensión

Qué ocurre: El docente da una instrucción o explica un contenido y pregunta «¿lo habéis entendido?». Nadie responde negativamente. El docente interpreta el silencio como confirmación de comprensión y continúa.

Consecuencia real: Las personas que no han comprendido raramente lo dicen en público, especialmente si han tenido experiencias previas en que reconocer la falta de comprensión fue interpretado negativamente. Para personas con discapacidad intelectual, con TDAH o con dificultades de procesamiento, la distancia entre lo que se comprende y lo que se puede articular en tiempo real puede ser significativa. El silencio es solo la ausencia de voz, no la presencia de comprensión.

Alternativa: Usar verificación activa de la comprensión: pedir a alguien que explique con sus palabras lo que acaba de escuchar, o que describa cuál es el primer paso que va a dar. Esta estrategia es más informativa, más justa y, cuando se normaliza como práctica de aula, elimina el estigma asociado a no haber comprendido.

ERROR 17 — No considerar el impacto de la medicación

Qué ocurre: El docente no tiene en cuenta que determinadas personas pueden estar tomando medicación cuyos efectos secundarios afectan directamente al rendimiento en el aula: sedación diurna, enlentecimiento cognitivo, sequedad de boca que dificulta el habla, temblor que interfiere con la escritura, o fluctuaciones de concentración relacionadas con los ciclos de la medicación.

Consecuencia real: El rendimiento variable que generan los efectos secundarios de la medicación se interpreta como inconsistencia, falta de esfuerzo o mala actitud. La persona no recibe los ajustes que necesitan sus circunstancias reales, que no tienen que ver con su capacidad sino con la gestión de su tratamiento.

Alternativa: En la conversación inicial sobre necesidades, incluir de forma natural la pregunta sobre si hay algún momento del día en que el rendimiento es mejor o peor, o si hay algún factor que el docente debería conocer para organizar mejor las actividades. No es necesario conocer el diagnóstico ni el tratamiento específico para adaptar el horario de las actividades más exigentes al momento de mayor funcionamiento de la persona.

ERROR 18 — Diseñar el itinerario de inserción desde las limitaciones

Qué ocurre: El técnico de inserción elabora el itinerario de la persona con discapacidad partiendo de una lista de lo que no puede hacer, lo que le cuesta y lo que le falta, en lugar de partir de una evaluación de sus capacidades, sus intereses y sus fortalezas.

Consecuencia real: Los itinerarios diseñados desde el déficit llevan a personas a empleos que nadie elegiría si pudiera elegir. Producen inserciones formalmente exitosas —la persona consigue un contrato— pero que no tienen en cuenta ni la motivación ni las aspiraciones de la persona, lo que reduce drásticamente las probabilidades de mantenimiento del empleo.

Alternativa: Empezar siempre por la pregunta de qué quiere hacer la persona, qué le gusta, en qué contextos se ha sentido bien y competente, y qué tipo de trabajo le daría satisfacción. Después, identificar las barreras entre ese punto de destino y la situación actual, y diseñar el itinerario para resolver esas barreras específicas.

ERROR 19 — No involucrar a la persona en las decisiones sobre su proceso

Qué ocurre: Las decisiones sobre el itinerario formativo, las adaptaciones, los ajustes razonables en el puesto de trabajo o la modalidad de inserción se toman entre profesionales, con la familia o con los servicios de apoyo, sin que la persona con discapacidad participe activamente en ese proceso.

Consecuencia real: Se vulnera el derecho fundamental a la autodeterminación. La persona aprende que su vida se decide en otro lugar, por otras personas, con criterios que no conoce. El impacto sobre la autonomía, la autoestima y la motivación para el propio proceso es severo y consistente con lo que la investigación describe como indefensión aprendida.

Alternativa: La persona con discapacidad es siempre el centro del proceso, no su objeto. Esto significa que participa en las reuniones donde se toman decisiones sobre su itinerario, que sus preferencias tienen peso real en esas decisiones, y que los profesionales actúan como facilitadores de su proyecto, no como árbitros del mismo.

ERROR 20 — Celebrar la inclusión sin evaluar si está ocurriendo realmente

Qué ocurre: El centro formativo o el servicio de orientación se presenta como inclusivo porque tiene protocolos escritos, porque ha realizado formación en discapacidad o porque tiene alumnos con discapacidad matriculados. No evalúa si esas personas están participando, aprendiendo y sintiéndose parte del grupo en igualdad real de condiciones.

Consecuencia real: La inclusión nominal sin inclusión real es, en el mejor de los casos, una oportunidad perdida. En el peor, es un entorno en el que la persona con discapacidad está presente pero excluida, lo cual puede ser más dañino que la exclusión explícita porque no hay forma de nombrarlo ni de reclamarlo.

Alternativa: Evaluar la inclusión de forma sistemática y con indicadores concretos: ¿participa la persona en las actividades en igualdad de condiciones? ¿Tiene relaciones sociales dentro del grupo? ¿Su rendimiento refleja su nivel real de conocimiento? ¿Ha podido comunicar sus

necesidades y han sido atendidas? ¿Cómo describe ella misma su experiencia en el proceso? Las respuestas a estas preguntas son la única medida real de si la inclusión está ocurriendo.

Tabla 14.1 — Los 20 errores y sus alternativas

Error	Consecuencia principal	Alternativa clave
1. Hablar sobre la persona sin dirigirse a ella	Exclusión simbólica, pérdida de voz	Dirigirse siempre directamente a la persona
2. Asumir capacidades sin preguntar	Exclusión o falta de apoyo donde se necesita	Conversación privada de evaluación al inicio
3. Infantilizar	Deterioro de la dignidad y la motivación	Mismo registro base para todos, ajuste solo en estructura
4. Reducir exigencia sin consenso	Certificación que no refleja aprendizaje real	Separar ajuste de canal de reducción de objetivos
5. Exponer necesidades sin consentimiento	Pérdida de control sobre información sensible	Preguntar siempre qué quiere compartir y cómo
6. Interpretar fatiga como desinterés	Retroalimentación negativa sobre síntoma involuntario	Pausas regulares, pregunta privada sobre el estado
7. Completar frases por la persona	Reducción progresiva de la comunicación autónoma	Esperar, ofrecer opciones, no llenar el silencio
8. Lenguaje estigmatizante	Marco negativo interiorizado por toda el aula	Lenguaje centrado en la persona, sistemático y natural
9. No anticipar barreras del entorno	Exclusión el mismo día de la sesión	Verificación de accesibilidad como parte de la preparación
10. Gestión diferenciada de conflictos sin causa	Falta de feedback o sanción injusta	Mismas normas de equidad, añadiendo comprensión de la causa
11. Sobreproteger	Indefensión aprendida, bloqueo del desarrollo de autonomía	Apoyo que tiene como objetivo volverse innecesario
12. No documentar acuerdos	Renegociación repetida, pérdida de derechos	Registro escrito desde el inicio, con consentimiento
13. Confundir conducta con diagnóstico	Pérdida de información contextual relevante	Observar en contexto, preguntar antes de concluir
14. Tratar ajustes como favores	Reducción de solicitudes de apoyo por coste emocional	Ajustes como derechos, implementados con naturalidad
15. No actualizar conocimientos	Práctica basada en evidencia obsoleta	Formación continua como responsabilidad ética

16. Interpretar silencio como comprensión	Acumulación de incomprensión no detectada	Verificación activa, pregunta que requiere respuesta observable
17. Ignorar impacto de la medicación	Variabilidad de rendimiento malinterpretada	Preguntar sobre momentos de mejor funcionamiento
18. Diseñar desde las limitaciones	Itinerario que nadie elegiría, baja motivación	Partir de capacidades, intereses y aspiraciones
19. Excluir a la persona de sus decisiones	Vulneración de la autodeterminación	La persona siempre en el centro, no como objeto del proceso
20. Inclusión nominal sin evaluación	Presencia sin participación real	Indicadores concretos de inclusión real, evaluados periódicamente

CAPÍTULO 15: GUÍA RÁPIDA PARA DOCENTES

Cómo usar este capítulo

Este capítulo es una referencia de consulta rápida. No sustituye a los capítulos anteriores, que ofrecen la comprensión profunda necesaria para una práctica realmente inclusiva. Es el lugar al que acudir cuando hay una sesión en dos horas y se necesita saber con precisión qué hacer en una situación concreta.

Cada sección está organizada de la misma forma: qué puede estar experimentando la persona, qué señales son observables, qué hacer antes de la sesión, qué hacer durante la sesión, qué hacer en la evaluación, y qué evitar de forma absoluta.

Si el alumno tiene discapacidad física

Qué puede estar experimentando

Gestión continua del dolor, la fatiga o la espasticidad en paralelo a la participación en la sesión. Cálculo constante de la energía disponible. Dependencia de un entorno físico que con frecuencia no está diseñado para ella. Incomodidad postural acumulada en sesiones largas. En condiciones degenerativas o variables, incertidumbre sobre cómo va a ser el día de hoy.

Señales observables

Cambios frecuentes de postura o dificultad para mantenerse en una misma posición. Fatiga visible que no guarda proporción con la actividad realizada. Dificultad con la escritura manual o con la manipulación de materiales. Llegadas tarde relacionadas con dificultades de desplazamiento. Ausencias que siguen un patrón de variabilidad sintomática.

Antes de la sesión

Verificar que el espacio es accesible: entrada, mesa de trabajo, materiales, aseos. Organizar el mobiliario para que la persona pueda moverse sin depender de que otros aparten sillas. Preparar los materiales en formatos que no requieran esfuerzo físico adicional para acceder a ellos. Tener una conversación privada al inicio del proceso para conocer necesidades específicas y preferencias.

Durante la sesión

Incorporar descansos regulares como norma del grupo, no como excepción para una persona. Asegurarse de que los materiales y las actividades prácticas son accesibles desde el puesto de la persona. Dirigirse siempre directamente a la persona, no al acompañante si lo hay. Ofrecer alternativas en actividades que requieren movilidad o destreza motora fina sin señalar a la persona ante el grupo.

En la evaluación

Ofrecer tiempo ampliado. Permitir el uso de ordenador u otros dispositivos cuando la escritura manual es la barrera. Considerar el examen oral como alternativa válida. Diseñar instrumentos que midan el conocimiento, no la velocidad de ejecución motora.

Evitar de forma absoluta

Hablar sobre la persona a través de su acompañante. Asumir que no puede participar en alguna actividad sin haberlo explorado con ella. Señalar al grupo sus limitaciones o

adaptaciones sin su consentimiento. Tratar la variabilidad de rendimiento como inconsistencia o falta de compromiso.

Si el alumno tiene discapacidad visual

Qué puede estar experimentando

Acceso parcial o nulo a todos los elementos visuales de la sesión: diapositivas, pizarra, esquemas, vídeos, expresiones faciales del grupo. Esfuerzo continuo de procesamiento auditivo para compensar la información visual perdida. Dependencia de que los materiales lleguen en formatos accesibles, lo que raramente ocurre de forma espontánea. En entornos nuevos, desorientación espacial hasta conocer la distribución del lugar.

Señales observables

Postura de acercamiento a los materiales escritos o a la pantalla. Solicitud de que se repita información que fue presentada solo visualmente. Dificultad para localizar elementos en el aula. No reacción ante señales o gestos visuales del docente. Uso de lector de pantalla, línea braille o amplificador de pantalla.

Antes de la sesión

Enviar los materiales con antelación suficiente, en formato digital accesible (Word o PDF etiquetado, nunca imagen de texto). Verificar que los vídeos tienen audiodescripción o preparar la descripción verbal propia. Asegurarse de que el espacio no tiene obstáculos en los pasos habituales. Conocer qué tecnologías de apoyo usa la persona y comprobar la compatibilidad del entorno.

Durante la sesión

Describir verbalmente todos los elementos visuales que se presenten: «en este gráfico se muestran tres barras, la primera representa...». Anunciar los cambios de actividad o de material oralmente, sin asumir que la transición visual es perceptible. Asegurarse de que el contraste de los materiales proyectados es suficiente. No señalar elementos en la pantalla sin describir verbalmente qué se está señalando.

En la evaluación

Proporcionar la prueba en formato digital accesible. Permitir el uso del lector de pantalla o de la línea braille. Ofrecer tiempo ampliado. Usar el examen oral cuando el formato escrito es la barrera principal. Eliminar cualquier elemento de evaluación que sea exclusivamente visual sin descripción alternativa.

Evitar de forma absoluta

Presentar información solo en formato visual sin descripción verbal. Enviar documentos como imágenes de texto. Usar expresiones deícticas sin referente verbal: «como veis aquí», «esto de la derecha», «el gráfico azul». Subir materiales a última hora sin tiempo para que la persona los convierta a su formato accesible.

Si el alumno tiene discapacidad auditiva

Qué puede estar experimentando

Acceso parcial o nulo a la comunicación oral que ocurre en el aula. Esfuerzo intenso y agotador de lectura labial durante toda la sesión, con la consciencia de que solo capta entre un 30 y un 40% de lo que se dice. En el caso de usuarios de LSE, dependencia de la

presencia y puntualidad del intérprete. Exclusión sistemática de los intercambios espontáneos, los comentarios en voz baja y las conversaciones informales que construyen el tejido social del grupo.

Señales observables

Concentración intensa en el rostro del docente, especialmente en los labios. Pérdida del hilo cuando el docente se gira, se mueve o habla sin que la persona tenga visibilidad directa. Retraso en la respuesta a preguntas o instrucciones orales. No reacción ante señales exclusivamente sonoras. Uso de audífono, implante coclear o comunicación con intérprete.

Antes de la sesión

Enviar el material de la sesión con antelación para que la persona pueda prepararse. Asegurarse de que el intérprete, si lo hay, ha recibido también el material previo. Activar la subtítulos automática si se van a proyectar vídeos. Verificar que la distribución del aula permite a la persona ver el rostro del docente y, si hay intérprete, verlo a él simultáneamente.

Durante la sesión

Mantener visibilidad del rostro en todo momento al hablar: no dar clase de espaldas, no hablar mientras se escribe en la pizarra, no cubrirse la boca. Complementar todas las instrucciones orales con soporte escrito visible. Establecer un turno de palabra claro en los debates para que la persona pueda seguir los intercambios. Resumir por escrito los puntos principales de los debates y las conclusiones.

En la evaluación

Proporcionar todas las instrucciones de la prueba por escrito. Asegurarse de que no hay componentes de evaluación exclusivamente orales sin alternativa. Contar con intérprete si la persona lo usa como lengua principal. Considerar que el castellano escrito puede ser la segunda lengua de personas cuya primera lengua es la LSE, con las implicaciones que eso tiene para la producción escrita.

Evitar de forma absoluta

Hablar de espaldas o de perfil. Dar instrucciones exclusivamente orales sin soporte escrito. Proyectar vídeos sin subtítulos. Interpretar la falta de reacción a señales sonoras como desinterés. Asumir que el audífono o el implante resuelven completamente la barrera de comunicación.

Si el alumno tiene TEA

Qué puede estar experimentando

Procesamiento sensorial del entorno sin los filtros automáticos que tienen las personas neurotípicas: el ruido, la luz, los olores y el movimiento compiten en intensidad similar con la voz del docente. Esfuerzo consciente y continuo de decodificación de las señales sociales implícitas del aula. Estado de vigilancia ante la posibilidad de que ocurra algo inesperado que no pueda anticipar. En entornos no predecibles, ansiedad de fondo que consume recursos cognitivos que deberían estar disponibles para el aprendizaje.

Señales observables

Dificultad para tolerar determinados estímulos sensoriales: luz intensa, ruidos bruscos, aglomeraciones. Reacción de malestar o de cierre ante cambios no anunciados en la rutina. Comunicación más literal de lo habitual, con dificultad para captar ironía o dobles sentidos. Preferencia por posiciones predecibles en el aula. Dificultad para las actividades grupales no estructuradas. En situaciones de sobrecarga, desconexión o reacción intensa que puede malinterpretarse como conducta disruptiva.

Antes de la sesión

Proporcionar un esquema visual de lo que va a ocurrir en la sesión y en qué orden. Comunicar con antelación cualquier cambio respecto a la rutina habitual: cambio de aula, cambio de horario, actividad nueva, presencia de personas externas. Si hay una exposición oral, un debate o una simulación, comunicarlo con antelación suficiente para que la persona pueda procesarlo y prepararse.

Durante la sesión

Usar un lenguaje directo y literal, evitando expresiones ambiguas, metáforas no explicadas o instrucciones que requieran deducción del subtexto. Anunciar las transiciones entre actividades con señal clara y tiempo previo. Dar instrucciones escritas además de orales. Tener disponible un sistema de señal acordado de antemano para que la persona pueda comunicar sobrecarga sin tener que hacerlo verbalmente en público.

En la evaluación

Comunicar el formato exacto de la evaluación con la mayor antelación posible. Ofrecer espacio alternativo si el entorno colectivo genera sobrecarga sensorial. Permitir el uso de guión o de notas en exposiciones orales. Usar instrumentos sin ambigüedad en los enunciados. Considerar el portfolio o el trabajo de aplicación como alternativas válidas al examen convencional.

Evitar de forma absoluta

Introducir cambios sin aviso. Usar sarcasmo, ironía o dobles sentidos sin explicarlos. Forzar la participación en dinámicas grupales no estructuradas sin preparación previa. Interpretar el malestar ante cambios como conducta manipuladora o caprichosa. Exponer públicamente las dificultades de la persona sin su consentimiento.

Si el alumno tiene discapacidad intelectual**Qué puede estar experimentando**

Dificultad para procesar instrucciones complejas o encadenadas, especialmente cuando se dan a un ritmo que no permite la verificación paso a paso. Mayor esfuerzo para acceder a conceptos abstractos no vinculados a la experiencia directa. Necesidad de más repetición espaciada para consolidar un aprendizaje que, una vez consolidado, se mantiene con la misma estabilidad que en cualquier otra persona. Experiencia acumulada de ser evaluada por debajo de su comprensión real, porque la expresión verbal espontánea no siempre refleja lo que realmente ha entendido.

Señales observables

Dificultad para iniciar una tarea sin que se haya modelado previamente. Pérdida de los pasos intermedios en instrucciones de más de dos o tres elementos. Respuesta correcta con demora mayor a la esperada. Expresión verbal más limitada que la comprensión real. Dificultad para generalizar un aprendizaje de un contexto a otro sin enseñanza explícita. Mayor facilidad con lo concreto que con lo abstracto.

Antes de la sesión

Preparar las instrucciones de las actividades en pasos numerados con verbos de acción concretos. Preparar apoyos visuales que acompañen las explicaciones orales: pictogramas, esquemas, ejemplos físicos. Si hay una actividad grupal, preparar la asignación de roles por escrito con la descripción exacta de lo que hace cada persona.

Durante la sesión

Dar las instrucciones de una en una, verificando la comprensión antes de dar la siguiente. Modelar las tareas antes de pedir las: mostrar cómo se hace antes de que la persona lo intente sola. Usar ejemplos concretos y cercanos a la experiencia de la persona antes de la definición abstracta. Dar tiempo real de procesamiento entre la pregunta y la respuesta esperada, sin llenar el silencio.

En la evaluación

Ofrecer tiempo ampliado. Simplificar los enunciados sin reducir el nivel de conocimiento que se evalúa. Usar la demostración práctica o la entrevista de evaluación cuando la producción escrita es la barrera. Diseñar rúbricas con descriptores concretos y observables para la autoevaluación. Reconocer el progreso individual además del nivel absoluto.

Evitar de forma absoluta

Infantilizar el tono o el vocabulario sin necesidad. Asumir que la dificultad de expresión refleja la dificultad de comprensión. Dar varias instrucciones encadenadas y esperar que se recuerden todas. Reducir la exigencia sin consensuarlo con la persona. No preguntar qué quiere hacer: diseñar el itinerario solo desde lo que el sistema considera posible para ella.

Si el alumno tiene TDAH**Qué puede estar experimentando**

No dificultad de atención en sentido literal, sino dificultad en la regulación voluntaria de hacia dónde va esa atención: puede concentrarse durante horas en algo que le resulta significativo y perder el hilo de forma involuntaria en algo que le resulta de baja estimulación. Fatiga atencional progresiva que en la segunda mitad de sesiones largas puede manifestarse como impulsividad, movimiento o irritabilidad, no como somnolencia. Dificultad para gestionar plazos, organizar la secuencia de una tarea compleja o recordar pasos intermedios cuando hay cualquier interrupción.

Señales observables

Pérdida del hilo en sesiones largas, especialmente pasada la primera hora. Respuestas verbales antes de que se haya terminado la pregunta. Dificultad para permanecer quieto períodos prolongados. Trabajo iniciado pero no terminado o terminado de forma apresurada al final. Rendimiento significativamente mejor en actividades prácticas o de alta estimulación que en tareas pasivas. Olvido frecuente de materiales, instrucciones o plazos.

Antes de la sesión

Planificar la sesión con bloques de no más de 20 minutos de escucha pasiva, alternados con actividades de participación activa. Preparar las instrucciones escritas de las actividades para que estén visibles durante toda la tarea. Pensar qué elementos del entorno pueden generar distracción innecesaria y reducirlos en lo posible.

Durante la sesión

Dar las instrucciones en pasos separados, con soporte visual permanente durante la actividad. Incorporar movimiento de forma planificada: actividades que impliquen levantarse, manipular, reorganizar o trabajar en distintos puntos del aula. Ofrecer retroalimentación frecuente y específica en lugar de solo al final del proceso. Si hay un sistema de turno de palabra, hacerlo explícito y visible para toda la clase.

En la evaluación

Ofrecer tiempo ampliado. Dividir la prueba en bloques con pausa entre ellos. Ofrecer el examen en espacio con menor estimulación si está disponible. Valorar portfolios y trabajos de proceso que distribuyen la evaluación en el tiempo. Ser consciente de que el rendimiento en los últimos ítems de una prueba larga puede no reflejar el nivel real de conocimiento, sino la fatiga atencional acumulada.

Evitar de forma absoluta

Interpretar la impulsividad verbal como mala educación o falta de respeto deliberada. Interpretar el movimiento como distracción o desinterés. Diseñar sesiones de más de una hora de escucha pasiva sin interrupción. Dar instrucciones complejas de forma oral sin soporte escrito. Sancionar conductas que pueden ser estrategias de autorregulación: manipular un objeto, cambiar de postura, tomar notas sin leerlas.

Tabla 15.1 — Lista de cotejo de inicio de sesión

Antes de empezar cualquier sesión con alumnado con discapacidad, el docente verifica:

Ítem	Sí	No	Pendiente
El espacio físico es accesible para todos los participantes	☐	☐	☐
Los materiales están en formatos accesibles para todos los perfiles	☐	☐	☐
Las instrucciones de las actividades están preparadas en pasos secuenciados	☐	☐	☐
Los vídeos que se van a proyectar tienen subtítulos o audiodescripción	☐	☐	☐
Se ha anticipado cualquier cambio respecto a la rutina habitual	☐	☐	☐
Hay pausas planificadas en la sesión	☐	☐	☐
La distribución del aula permite visibilidad del docente para todos	☐	☐	☐
Los instrumentos de evaluación han sido revisados para eliminar barreras de canal	☐	☐	☐
Se ha hablado con la persona en privado sobre sus necesidades específicas	☐	☐	☐
Hay un sistema de señal o comunicación pactado para situaciones de dificultad	☐	☐	☐

Tabla 15.2 — Resumen rápido: señales, necesidades y respuesta inmediata

Perfil	Señal observable	Necesidad real	Respuesta inmediata del docente
Discapacidad física	Incomodidad postural, fatiga visible	Descanso, ajuste físico del entorno	Pausa, verificar comodidad en privado
Discapacidad visual	No reacción a elementos visuales	Descripción verbal, formato accesible	Describir lo que se está proyectando
Discapacidad auditiva	Pérdida del hilo cuando el docente se gira	Visibilidad del rostro, soporte escrito	Girar hacia la persona, escribir la instrucción
TEA	Malestar ante cambio no anunciado	Anticipación, explicación del cambio	Explicar el cambio, el motivo y lo que sigue
Discapacidad intelectual	Tarea no iniciada tras la instrucción	Modelado, verificación del primer paso	Mostrar el primer paso, preguntar qué viene después
TDAH	Dispersión creciente, movimiento	Cambio de formato, estímulo diferente	Actividad de transición breve, retroalimentación
Discapacidad psicosocial	Retraimiento, ausencia de participación	Seguridad, ausencia de presión pública	No forzar intervención, contacto privado
DCA	Lentitud de respuesta, fatiga	Más tiempo, repetición sin presión	Dar tiempo real, no completar la respuesta
Fibromialgia / SFC	Variabilidad de rendimiento entre sesiones	Flexibilidad, validación	No interpretar variabilidad como falta de esfuerzo

ANEXOS

ANEXO 1: Lista de cotejo de aula inclusiva

Este instrumento está diseñado para ser revisado antes de cada ciclo formativo y, en los ítems marcados con asterisco, antes de cada sesión. No es una lista de requisitos mínimos. Es un mapa de la distancia entre el aula actual y el aula que permite que todas las personas participen en igualdad real de condiciones.

BLOQUE A — Espacio físico

Ítem	Sí	Parcialmente	No	Observaciones
La entrada al espacio formativo es accesible sin escalones ni barreras				
El ancho de las puertas permite el paso de una silla de ruedas				
Las mesas tienen altura regulable o existe al menos una mesa adecuada para silla de ruedas				
Los materiales de uso frecuente están al alcance sin necesidad de levantarse ni estirarse				
Los pasillos entre mesas permiten la circulación de una silla de ruedas sin mover el mobiliario				
Los aseos accesibles están identificados y disponibles				
La iluminación es suficiente y uniforme, sin zonas de sombra sobre el área de trabajo				
No hay fuentes de luz que generen reflejos en las superficies de trabajo o en la pantalla				
La acústica de la sala permite la comprensión de la voz a distancia sin esfuerzo excesivo				
Hay un espacio tranquilo disponible para pausas sensoriales si se necesita				

BLOQUE B — Materiales y contenidos

Ítem	Sí	Parcialmente	No	Observaciones
Los documentos escritos tienen fuente mínima de 12 puntos (preferiblemente 14)	☐	☐	☐	
El contraste entre texto y fondo es suficiente (texto oscuro sobre fondo claro o viceversa)	☐	☐	☐	
Los documentos digitales son accesibles para lectores de pantalla (no imágenes de texto)	☐	☐	☐	
Los vídeos que se van a usar tienen subtítulos	☐	☐	☐	
Los vídeos que contienen información visual relevante tienen audiodescripción o se describirán verbalmente	☐	☐	☐	
Las instrucciones de las actividades están disponibles por escrito además de oralmente	☐	☐	☐	
Los materiales se han enviado con antelación suficiente a quien los necesite en formato alternativo	☐	☐	☐	
Los esquemas y gráficos tienen descripción textual alternativa	☐	☐	☐	
Los materiales en lectura fácil están disponibles cuando son necesarios	☐	☐	☐	
Las instrucciones de evaluación están redactadas con claridad y sin ambigüedad	☐	☐	☐	

BLOQUE C — Metodología

Ítem	Sí	Parcialmente	No	Observaciones
La sesión incluye pausas regulares planificadas	☐	☐	☐	
Las instrucciones se dan en pasos secuenciados y verificables	☐	☐	☐	
Se usa modelado antes de pedir la realización autónoma de tareas nuevas	☐	☐	☐	
Los cambios respecto a la rutina habitual se comunican con antelación	☐	☐	☐	
Se dispone de un esquema visible del orden de la sesión	☐	☐	☐	
Las dinámicas grupales tienen roles asignados de forma explícita	☐	☐	☐	
Los debates tienen un sistema de turno de palabra claro y visible	☐	☐	☐	
La verificación de comprensión es activa, no basada en la pregunta retórica	☐	☐	☐	
Se ofrecen alternativas de canal en las actividades cuando es posible	☐	☐	☐	
El ritmo de la sesión permite tiempo real de procesamiento entre instrucción y respuesta	☐	☐	☐	

BLOQUE D — Evaluación

Ítem	Sí	Parcialmente	No	Observaciones
Los instrumentos de evaluación miden el conocimiento y no el canal de acceso				
Está disponible la opción de tiempo ampliado para quien lo necesite				
Existe formato alternativo de evaluación documentado y disponible				
Los ajustes razonables en evaluación están registrados por escrito				
La retroalimentación es específica, accionable y privada cuando implica errores significativos				
Se reconoce el progreso individual además del nivel absoluto				
La evaluación no penaliza la variabilidad de rendimiento asociada a condiciones de salud				
Existe la posibilidad de examen oral como alternativa cuando la escritura es la barrera				

BLOQUE E — Clima y relación pedagógica

Ítem	Sí	Parcialmente	No	Observaciones
Se ha establecido una conversación privada con cada alumno con discapacidad sobre sus necesidades				
Los acuerdos de adaptación están documentados con el consentimiento de la persona				
El lenguaje usado en el aula está centrado en la persona, no en el diagnóstico				
La información sobre las necesidades de un alumno no se comparte sin su consentimiento				
Las adaptaciones se gestionan de la forma más discreta posible				
La persona participa activamente en las decisiones sobre su propio proceso				
Existe un sistema de señal acordado para comunicar sobrecarga o dificultad sin exposición pública				
El docente ha revisado sus propias actitudes y prejuicios respecto a la discapacidad				

ANEXO 2: lista de cotejo de accesibilidad para espacios formativos

Este instrumento es específico para la evaluación del espacio físico y tecnológico. Puede ser cumplimentado por el docente, por el técnico de prevención o por la propia persona con discapacidad como evaluadora experta de su entorno.

Acceso y circulación

Ítem	Estado	Acción necesaria
Entrada principal sin escalones o con rampa accesible (pendiente máx. 8%)		
Rampa con pasamanos a ambos lados		
Ascensor disponible si hay más de una planta (dimensiones mínimas 100x125 cm)		
Puertas con ancho libre mínimo de 80 cm		
Manillas de puertas accionables con una sola mano		
Suelo antideslizante y sin irregularidades		
Pasillos con anchura mínima de 90 cm, preferiblemente 120 cm		
Señalización visual y táctil en puntos de decisión		
Señalización en braille en ascensores y puntos clave		
Franjas de pavimento táctil en zonas de riesgo		

Espacio formativo

Ítem	Estado	Acción necesaria
Al menos una mesa y silla accesibles para persona usuaria de silla de ruedas		
Espacio libre de 1,5 m de diámetro para maniobra de silla de ruedas		
Pizarra o pantalla visible desde todos los puntos del aula		
Iluminación mínima de 500 lux en superficies de trabajo		
Ausencia de reflejos en pantallas y superficies de trabajo		
Control de iluminación accesible desde la entrada		
Temperatura regulable o ventilación suficiente		
Nivel de ruido en condiciones normales inferior a 40 dB		
Sistema de bucle magnético instalado o disponible		
Conexión eléctrica suficiente para tecnologías de apoyo		

Tecnología y comunicación

Ítem	Estado	Acción necesaria
Proyector con suficiente resolución y contraste		
Sistema de amplificación de voz disponible		
Conexión a internet estable para tecnologías de apoyo en línea		
Software de subtítulos automática disponible o instalado		
Micrófono de solapa o inalámbrico disponible para el docente		
Ordenadores con software de accesibilidad instalado (lector de pantalla, amplificación)		
Impresora disponible para materiales en letra grande		
Sistema de alarma con señal visual además de sonora		
Señalización de emergencia accesible visualmente y táctilmente		
Plan de evacuación que incluye a personas con movilidad reducida		

ANEXO 3: cuestionario de autoevaluación docente

Este cuestionario no tiene puntuación. No genera una calificación de inclusividad. Genera reflexión. Las respuestas honestas a estas preguntas son el punto de partida para cualquier mejora real en la práctica profesional. Responde con total honestidad. Nadie más va a leer esto.

Sobre el conocimiento

1. ¿Puedo distinguir con precisión entre deficiencia, discapacidad, diversidad funcional y dependencia sin consultar ningún material?
2. ¿Conozco las diferencias funcionales principales entre los distintos tipos de discapacidad con los que puedo encontrarme en mi aula?
3. ¿Sé qué es el malestar post-esfuerzo y por qué es relevante para mi práctica docente?
4. ¿Conozco al menos tres tecnologías de apoyo que usan personas con discapacidad en contextos formativos y sé cómo hacer que mi entorno sea compatible con ellas?
5. ¿Puedo explicar la diferencia entre el modelo médico y el modelo social de la discapacidad con mis propias palabras?
6. ¿Conozco los ajustes razonables a los que tienen derecho las personas con discapacidad en contextos formativos según la normativa española vigente?

Sobre la práctica

7. En los últimos seis meses, ¿he tenido una conversación privada con cada alumno con discapacidad de mi grupo para preguntarle qué necesita y cómo prefiere que se gestione esa información?
8. ¿Verifico la accesibilidad del espacio físico y de los materiales antes de cada ciclo formativo?
9. ¿Mis materiales digitales son accesibles para lectores de pantalla?
10. ¿Los vídeos que uso en el aula tienen subtítulos?
11. ¿Mis instrumentos de evaluación miden el conocimiento o miden también el canal de acceso al conocimiento?
12. ¿Ofrezco sistemáticamente tiempo ampliado como ajuste normalizado, o solo cuando alguien lo solicita explícitamente?
13. ¿Mis instrucciones de actividades están disponibles por escrito además de oralmente?
14. ¿Incorporo pausas regulares en las sesiones largas de forma planificada, no espontánea?

Sobre las actitudes

15. Cuando un alumno con discapacidad tiene un rendimiento variable, ¿cuál es mi primera interpretación espontánea? ¿Busco la causa en la persona o en el entorno?
16. ¿Alguna vez he tomado una decisión sobre el itinerario o las actividades de un alumno con discapacidad sin consultarle?
17. ¿He compartido alguna vez información sobre la condición de un alumno con otros docentes o con el grupo sin el consentimiento explícito de esa persona?
18. Cuando pienso en un alumno con discapacidad, ¿lo pienso primero como persona con características, intereses y aspiraciones, o primero como portador de un diagnóstico?
19. ¿Me siento incómodo cuando un alumno con discapacidad tiene un rendimiento superior al de sus compañeros sin discapacidad? ¿Por qué?

20. ¿Alguna vez he simplificado el lenguaje o reducido la exigencia con una persona adulta con discapacidad sin que hubiera una razón funcional clara para hacerlo?

Sobre el desarrollo profesional

21. ¿Cuándo fue la última vez que leí un artículo, asistí a una formación o escuché a una persona con discapacidad hablar sobre su propia experiencia?
22. ¿Tengo acceso a un equipo de apoyo o a un asesor especializado en discapacidad al que puedo consultar cuando tengo dudas sobre cómo actuar?
23. ¿He revisado en el último año si mis prácticas de aula están alineadas con la evidencia actual sobre inclusión educativa?
24. ¿Conozco las entidades de referencia en discapacidad en mi comunidad autónoma a las que puedo derivar o con las que puedo colaborar?

Reflexión final

Identifica dos prácticas concretas de tu aula actual que mejorarían la participación de alumnado con discapacidad y que podrías implementar en la próxima sesión sin necesidad de recursos adicionales.

Práctica 1: _____

Práctica 2: _____

Identifica un área de conocimiento sobre discapacidad en la que sientes que necesitas formación específica.

Área: _____

ANEXO 4: casos prácticos resueltos

CASO 1 — El alumno que siempre llega tarde y se va antes

Situación: Raúl, 41 años, fibromialgia diagnosticada, está matriculado en un programa de formación para la inserción laboral. Llega sistemáticamente 20 minutos tarde a las sesiones matutinas y en ocasiones se marcha antes de que terminen. El docente lo ha amonestado dos veces por falta de puntualidad y compromiso. El rendimiento de Raúl en los contenidos es correcto cuando asiste.

Análisis: La fibromialgia produce con frecuencia mayor rigidez y dolor en las primeras horas de la mañana, lo que hace que las actividades matutinas tempranas sean especialmente difíciles. El cansancio acumulado puede hacer que las últimas horas de una sesión larga sean inabordables. Ninguno de estos factores es visible desde fuera ni tiene relación con la motivación o el compromiso.

Error cometido: El docente interpretó la variabilidad de presencia como falta de interés sin explorar las causas. Amonestó una conducta que era consecuencia de una condición de salud, no de una actitud.

Resolución: El docente solicita una reunión privada con Raúl. Le pregunta directamente si hay algún factor que esté afectando a su asistencia. Raúl explica la situación. Juntos acuerdan: asistencia flexible en los 20 primeros minutos de las sesiones matutinas sin penalización; acceso a los materiales y al resumen de los primeros minutos en formato digital; posibilidad de salir discretamente si la fatiga lo requiere; y una revisión del sistema de evaluación de la asistencia para que no penalice una variabilidad que tiene causa documentada.

Resultado: Raúl completa el programa. Su rendimiento en contenidos es el más alto de su grupo.

CASO 2 — La alumna que nunca interviene en los debates

Situación: Sofía, 25 años, TEA nivel 1 de apoyo, participa en un curso de orientación laboral. En las sesiones de debate grupal no interviene nunca. El docente interpreta esto como falta de preparación o de interés y comienza a pensar que Sofía no está aprovechando el curso.

Análisis: Los debates grupales con intervenciones espontáneas son uno de los formatos de mayor dificultad para personas con TEA. La combinación de imprevisibilidad, múltiples voces simultáneas, necesidad de interpretar cuándo es el momento de hablar y exposición social en tiempo real supera la capacidad de procesamiento disponible para participar de forma espontánea, aunque el conocimiento del tema sea sólido.

Error cometido: El docente evaluó la participación exclusivamente por la visibilidad oral en el debate, sin explorar canales alternativos ni las razones de la no participación.

Resolución: El docente habla con Sofía en privado. Sofía explica que sí tiene opiniones sobre los temas pero que en el debate no puede organizarlas y expresarlas a la velocidad que requiere el formato. Acuerdan: que Sofía prepare por escrito su posición antes del debate y pueda leerla o tenerla como referencia durante su intervención; que el docente le anticipe el momento en que le dará la palabra; y que como alternativa complementaria, Sofía pueda entregar un documento escrito con su análisis del tema debatido.

Resultado: En el siguiente debate, Sofía interviene dos veces. Su análisis es el más estructurado del grupo. El docente revisa su sistema de valoración de la participación.

CASO 3 — El trabajador que no rinde en el nuevo puesto

Situación: Miguel, 35 años, DCA por traumatismo craneoencefálico hace tres años, ha sido insertado en un puesto administrativo mediante un programa de empleo con apoyo. Al finalizar el período de acompañamiento del preparador laboral, la empresa comunica que Miguel comete errores frecuentes, tarda más de lo esperado en completar las tareas y en algunas reuniones parece perdido.

Análisis: El DCA puede producir lentitud de procesamiento, fatiga cognitiva y dificultades de memoria de trabajo que no son evidentes en las primeras semanas de incorporación pero que se hacen visibles cuando el apoyo externo se retira y la persona debe gestionar sola la complejidad creciente del puesto. Los errores frecuentes y la lentitud son síntomas funcionales, no falta de capacidad ni de esfuerzo.

Error cometido: El apoyo del preparador laboral se retiró demasiado pronto, sin haber verificado que la persona había consolidado los mecanismos de compensación necesarios para funcionar de forma autónoma en situaciones de complejidad creciente.

Resolución: El preparador laboral reactiva el apoyo presencial durante dos semanas. Se identifican las situaciones concretas que generan más dificultad: las reuniones con varios interlocutores y las tareas con varios pasos simultáneos. Se acuerdan con la empresa tres ajustes razonables: acceso al orden del día de las reuniones con antelación; instrucciones de tareas complejas por escrito; y una persona de referencia en el equipo a quien Miguel puede preguntar cuando tiene dudas sin tener que identificar quién es el interlocutor adecuado en cada caso. Los errores disminuyen en dos semanas. Miguel sigue en el puesto dos años después.

CASO 4 — La alumna a quien nadie preguntó qué quería

Situación: Laura, 29 años, discapacidad intelectual leve, lleva cuatro años en un Centro Ocupacional realizando tareas de manualidades y jardinería. Su técnica de referencia propone renovar su itinerario. En la reunión de planificación participan la técnica, la directora del centro y la madre de Laura. Laura no está en la reunión.

Análisis: La autodeterminación es un derecho fundamental y un predictor consistente del bienestar y de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Tomar decisiones sobre el itinerario de una persona adulta sin su participación activa vulnera ese derecho independientemente de las buenas intenciones de quienes lo hacen.

Error cometido: Laura fue excluida de la toma de decisiones sobre su propio proyecto de vida. Su madre y los profesionales asumieron que conocían mejor que ella lo que necesitaba.

Resolución: Se cancela la reunión y se programa una nueva con Laura como participante central. Se le explica el objetivo de la reunión con antelación y con apoyos visuales si son necesarios para facilitar su comprensión. En la reunión, se le pregunta directamente: qué le gusta hacer, qué no le gusta, en qué entornos se ha sentido bien, qué tipo de trabajo le gustaría tener. Laura expresa que le gustan las plantas pero que preferiría trabajar en una floristería antes que en jardinería de exterior porque en invierno el frío le afecta. También dice que le gustaría ganar dinero de verdad. El itinerario resultante incluye prácticas en una floristería con apoyo del preparador laboral. Seis meses después, Laura tiene un contrato en prácticas.

ANEXO 5: actividades reales para desarrollar empatía

Estas actividades están diseñadas para grupos de docentes, orientadores o técnicos de inserción en formación. Su objetivo es generar comprensión vivencial de algunas de las experiencias que tienen las personas con discapacidad en entornos formativos. No simulan la discapacidad. Simulan situaciones de barrera, que es lo que el modelo social identifica como el problema real.

ACTIVIDAD 1 — Una sesión con sobrecarga sensorial

Duración: 20 minutos.

Materiales: Música de fondo a volumen medio, luz fluorescente si está disponible, el docente lleva auriculares de cancelación de ruido durante la actividad.

Dinámica: El facilitador imparte una explicación de 15 minutos sobre un contenido técnico nuevo mientras en la sala hay música de fondo a volumen moderado, la iluminación es intensa y el facilitador habla de cara a la ventana (contra la luz). Al finalizar, los participantes deben responder por escrito cinco preguntas sobre el contenido.

Reflexión guiada: ¿Cuánto esfuerzo ha supuesto intentar atender? ¿Qué partes de la explicación se perdieron? ¿Qué habría necesitado para poder seguir mejor? ¿Cómo habría sido la experiencia durante tres horas en lugar de veinte minutos, y durante semanas en lugar de un día?

Conexión con la práctica: Esta es una aproximación muy parcial a lo que puede experimentar una persona con hipersensibilidad sensorial, con discapacidad auditiva que lee los labios, o con TDAH en un entorno con múltiples distractores. La diferencia es que para ellas no tiene fin al cabo de veinte minutos.

ACTIVIDAD 2 — Instrucciones imposibles

Duración: 15 minutos.

Materiales: Hojas de papel, bolígrafos.

Dinámica: El facilitador da verbalmente, sin repetir y sin soporte escrito, una instrucción de seis pasos encadenados para realizar una tarea de organización de información. Los pasos incluyen criterios abstractos, condicionales y proyecciones temporales. Los participantes deben intentar completar la tarea.

Reflexión guiada: ¿Cuántos pasos se recordaron completos? ¿Cuál fue la sensación de no poder pedir que se repitiera? ¿Qué habría cambiado si la instrucción hubiera estado escrita y secuenciada? ¿Cómo habría afectado al rendimiento que esto ocurriera en cada actividad, durante semanas?

Conexión con la práctica: Esta actividad reproduce parcialmente lo que experimenta una persona con discapacidad intelectual, con TDAH o con DCA ante instrucciones complejas dadas exclusivamente de forma oral. La diferencia es que los participantes saben que la dificultad es del diseño de la actividad. Las personas con discapacidad llevan años escuchando que la dificultad es de ellas.

ACTIVIDAD 3 — La reunión sin voz

Duración: 20 minutos.

Dinámica: Se simula un debate grupal sobre un tema profesional. Una persona del grupo tiene asignado el rol de observador silencioso: puede ver el debate pero no puede intervenir, no puede pedir que repitan algo y no puede comunicar que no ha entendido. Al finalizar, debe responder preguntas sobre los acuerdos alcanzados en el debate.

Reflexión guiada: ¿Qué se sintió al tener información pero no poder acceder a ella ni aportarla? ¿Cuándo se perdió el hilo? ¿Cuál fue el impacto emocional de estar presente pero excluido? ¿Qué habría cambiado si hubiera habido un canal de participación alternativo?

Conexión con la práctica: Esta actividad reproduce parcialmente la experiencia de una persona con discapacidad auditiva en un debate oral sin adaptaciones, o de una persona con dificultades expresivas graves en un entorno que solo valora la participación oral espontánea.

ACTIVIDAD 4 — El itinerario que nadie te preguntó

Duración: 30 minutos.

Dinámica: En parejas. Una persona hace el rol de técnico de inserción y la otra hace el rol de persona con discapacidad. El técnico tiene una ficha con el diagnóstico de la persona y una lista de empleos disponibles. Tiene cinco minutos para diseñar el itinerario de inserción. La norma es que no puede hacer ninguna pregunta a la persona sobre sus intereses, preferencias o experiencias.

En la segunda fase, el técnico repite el proceso pero ahora puede hacer todas las preguntas que quiera antes de proponer nada.

Reflexión guiada: ¿Qué diferencia hubo entre los dos itinerarios? ¿El primero reflejaba a la persona? ¿Qué información fue la más relevante para cambiar la propuesta? ¿Con qué frecuencia en la práctica real se diseñan itinerarios más parecidos a la primera fase que a la segunda?

ACTIVIDAD 5 — El texto inaccesible

Duración: 10 minutos.

Materiales: Un texto técnico de una página fotocopiado en baja calidad, con fuente de 8 puntos, fondo gris y sin estructura de párrafos. Tiempo límite: 5 minutos para leer y resumir en tres frases.

Reflexión guiada: ¿Cuánto del contenido se pudo procesar? ¿Qué generó la presión del tiempo? ¿El problema era el contenido o el formato? ¿Qué habría ocurrido si eso hubiera sido el material de un examen?

Conexión con la práctica: Esta es una representación de la experiencia de una persona con baja visión, con dislexia o con dificultades de procesamiento lector ante materiales no diseñados con criterios de accesibilidad. El contenido puede ser perfectamente accesible. El canal lo hace inaccesible.

ANEXO 6: recursos y entidades de referencia

Organismos nacionales

CERMI — Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

Plataforma de representación del movimiento asociativo de personas con discapacidad en España. Publica informes, propuestas legislativas y recursos sobre todos los ámbitos de la discapacidad.

Web: cermi.es

ONCE — Organización Nacional de Ciegos Españoles

Referencia en accesibilidad, tecnologías de apoyo para personas con discapacidad visual, y empleo. Dispone de recursos específicos para docentes y empresas.

Web: once.es

FEAPS / PLENA INCLUSIÓN

Confederación española de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Recursos sobre educación inclusiva, vida independiente y empleo con apoyo.

Web: plenainclusion.org

FEDER — Federación Española de Enfermedades Raras

Organismo de referencia para enfermedades raras. Dispone de guías para docentes y entornos laborales sobre condiciones específicas.

Web: enfermedades-raras.org

FIAPAS — Federación Española de Asociaciones de Personas Sordas

Recursos sobre discapacidad auditiva, lengua de signos, accesibilidad comunicativa y empleo.

Web: fiapas.es

CNSE — Confederación Estatal de Personas Sordas

Referencia en Lengua de Signos Española, identidad Sorda y derechos de las personas sordas.

Web: cnse.es

FEDACE — Federación Española de Daño Cerebral

Recursos específicos sobre daño cerebral adquirido, reinserción laboral y adaptaciones en entornos formativos.

Web: fedace.org

IMSERSO — Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Gestión de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Información sobre grados de dependencia, catálogo de servicios y prestaciones económicas.

Web: imserso.es

SEPE — Servicio Público de Empleo Estatal

Información sobre contratos específicos para personas con discapacidad, incentivos a la contratación y programas de formación para el empleo.

Web: sepe.es

Recursos sobre accesibilidad

CAST — Center for Applied Special Technology

Marco internacional de referencia para el Diseño Universal para el Aprendizaje. Guías, herramientas y evidencia científica sobre cómo diseñar entornos de aprendizaje accesibles desde el principio.

Web: udlguidelines.cast.org

CEAPAT — Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas

Información sobre productos de apoyo, accesibilidad universal y tecnologías de asistencia.

Web: ceapat.imsero.es

W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

Estándares internacionales de accesibilidad web. Relevante para la creación de materiales digitales accesibles.

Web: w3.org/WAI

Normativa de referencia

Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)

Ratificada por España en 2008. Marco internacional de derechos que obliga a garantizar la inclusión en educación, empleo y vida comunitaria.

Real Decreto Legislativo 1/2013 — Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (LGDPD)

Norma de referencia en España para derechos, ajustes razonables y no discriminación.

Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Marco regulatorio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Real Decreto 870/2007 — Empleo con apoyo

Regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario.

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Relevante para la gestión de información sobre condiciones de salud de los alumnos.

Real Decreto 1/1995 — Estatuto de los Trabajadores

Marco laboral de referencia para los contratos, adaptaciones de puesto y obligaciones de las empresas en materia de discapacidad.

Lecturas recomendadas

- Schalock, R. L. y Verdugo, M. A. (2003). *Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales*. Alianza Editorial.
- Wehmeyer, M. L. (2005). Self-determination and individuals with severe disabilities: Re-examining meanings and misinterpretations. *Research and Practice for Persons with Severe Disabilities*, 30(3), 113-120.
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Macmillan.
- Meyer, A., Rose, D. H. y Gordon, D. (2014). *Universal Design for Learning: Theory and Practice*. CAST Professional Publishing.
- Steele, C. M. (1997). A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance. *American Psychologist*, 52(6), 613-629.
- Verdugo, M. A. y Schalock, R. L. (2013). *Discapacidad e inclusión: Manual para la docencia*. Amarú Ediciones.

Tabla final — Entidades por tipo de discapacidad

Tipo de discapacidad	Entidad de referencia principal	Recurso específico para docentes
Discapacidad física	COCEMFE	Guías de accesibilidad en centros formativos
Discapacidad visual	ONCE	Recursos didácticos accesibles, tiflotecnología
Discapacidad auditiva	CNSE, FIAPAS	Recursos LSE, subtítulos, accesibilidad comunicativa
Discapacidad intelectual	Plena Inclusión	Lectura fácil, empleo con apoyo, vida independiente
TEA	Autismo España	Guías de intervención educativa, estructuración del entorno
TDAH	FEAADAH	Recursos para docentes, estrategias de aula
Salud mental	SALUD MENTAL ESPAÑA	Guías de inclusión educativa y laboral
Daño cerebral adquirido	FEDACE	Adaptaciones en entornos formativos y laborales
Enfermedades raras	FEDER	Base de datos de enfermedades, recursos para docentes
Dependencia	IMSERSO	Catálogo de servicios, prestaciones, grados